114年度失智症照護政策研究成果研討會

失智者的安寧緩和照護實踐

Clinical Implementation of Palliative Care for Dementia

114年10月30日(星期四)16:10~16:30

張榮發基金會國際會議中心801廳

臺北榮民總醫院家庭醫學部林明慧主任

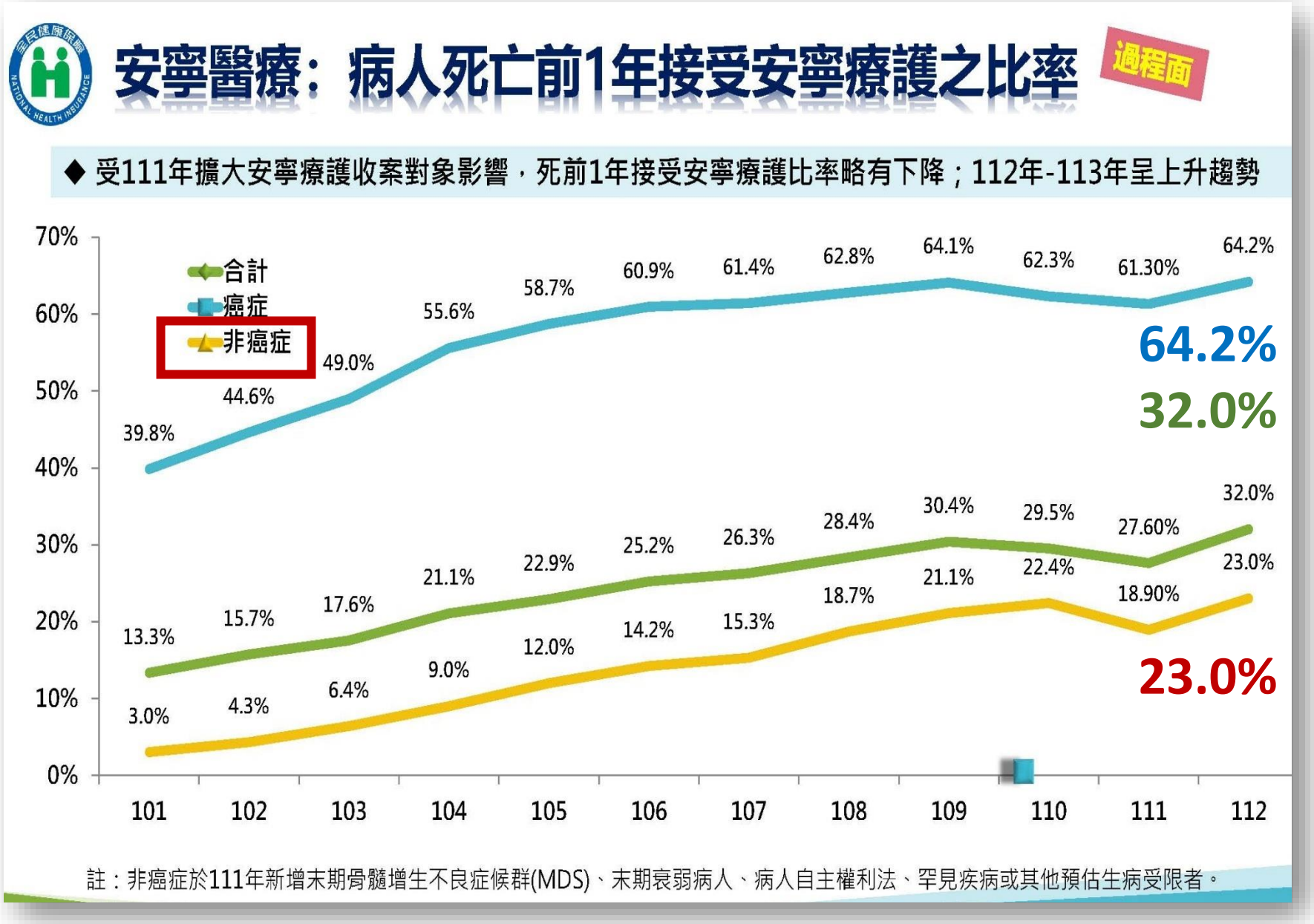
CC BY NC SA

【安寧涵蓋率】

非癌症末期病人/失智及老衰病人過世前接受安寧照護比例偏低。

本資料圖示摘錄自113年健保各總額部門(含門診透析)一般服務執行成果

https://www.mohw.gov.tw/dl-95973-483d0a2d-e7e6-4308-a632-dfb5ba13b1d9.html



112年全國社區失智症流行病學調查結果

年齡(歲)	65 歲以上	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	≧90
失智症盛行率(%)	7.99	2.40	5.16	9.10	16.00	20.04	29.45

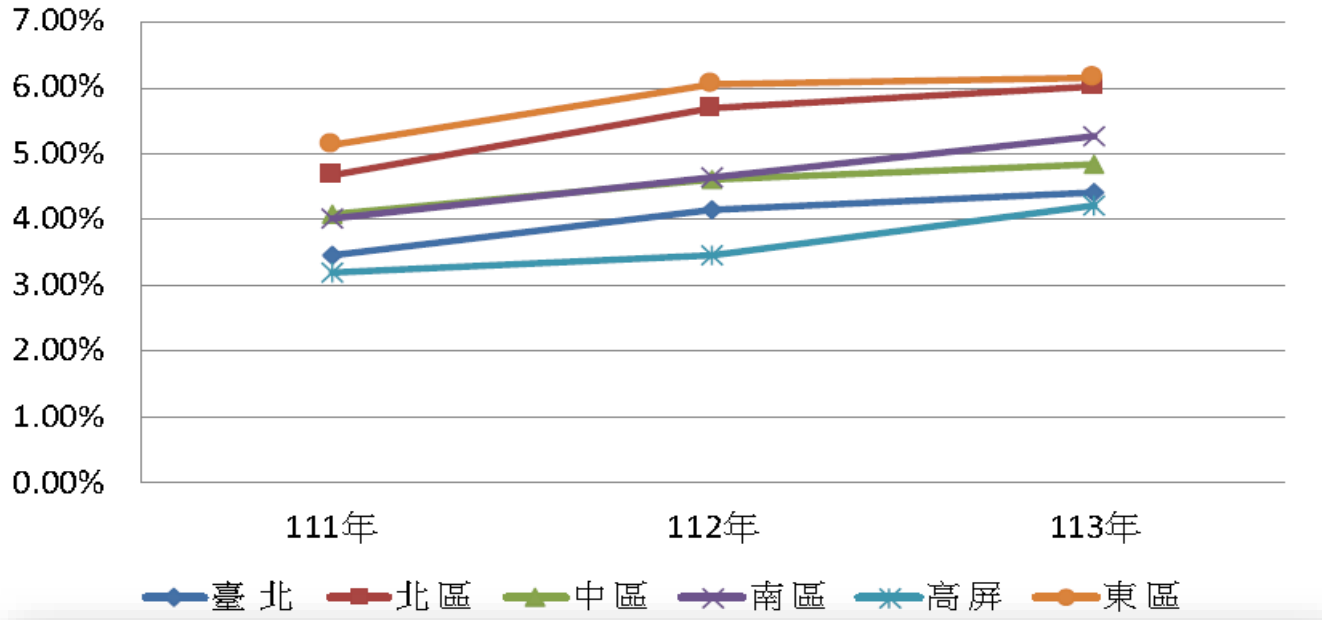
二、 失智個案之疾病嚴重度

CDR 分數 / 失智程度	0.5 極輕度	1 輕度	2 中度	3 重度	總數
占率(%)	17.08	33.85	24.22	24.84	100

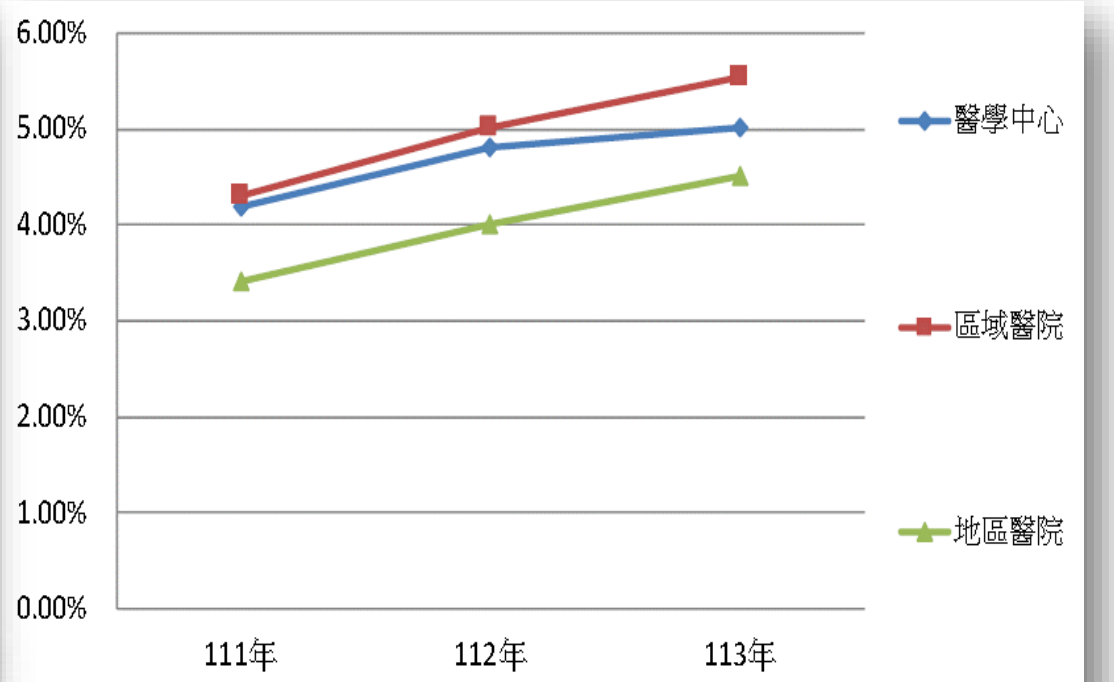
Q：依113年公告，臺灣失智症病人接受安寧緩和服務比率為?

4.83%

失智症病人接受安寧緩和服務比率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	3.44%	4.66%	4.08%	4.02%	3.19%	5.12%	3.81%
112年	4.14%	5.68%	4.61%	4.64%	3.47%	6.04%	4.44%
113年	4.40%	6.02%	4.83%	5.28%	4.22%	6.14%	4.83%



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
111年	4.19%	4.31%	3.41%
112年	4.82%	5.03%	4.01%
113年	5.02%	5.54%	4.51%

出處：113年醫院總額整體性醫療品質資訊公開報告

台灣失智症防治照護政策綱領 2.0版 (2017)

2025 年達成失智友善台灣

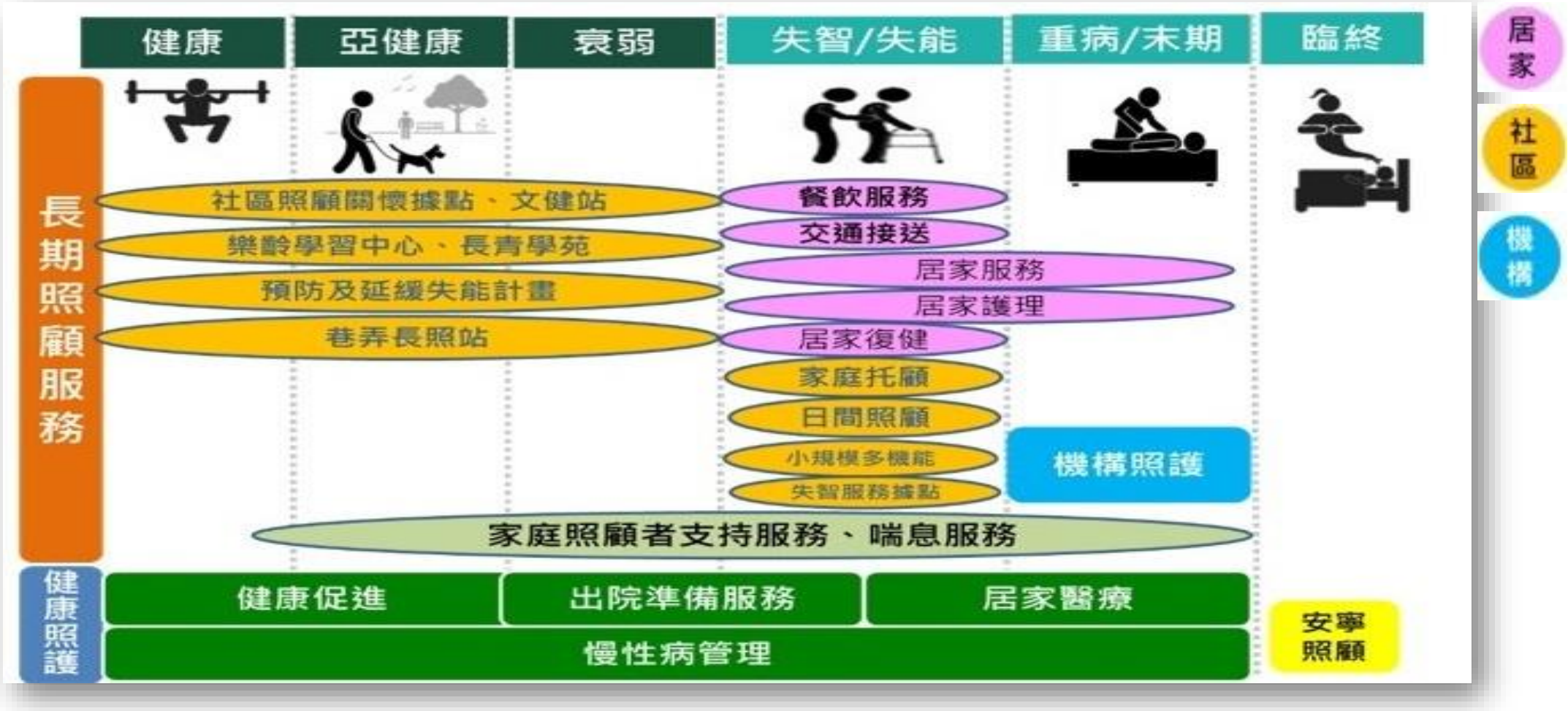
DEMENTIA FRIENDLY TAIWAN by 2025

4.健全失智症診斷、治療、照護網絡

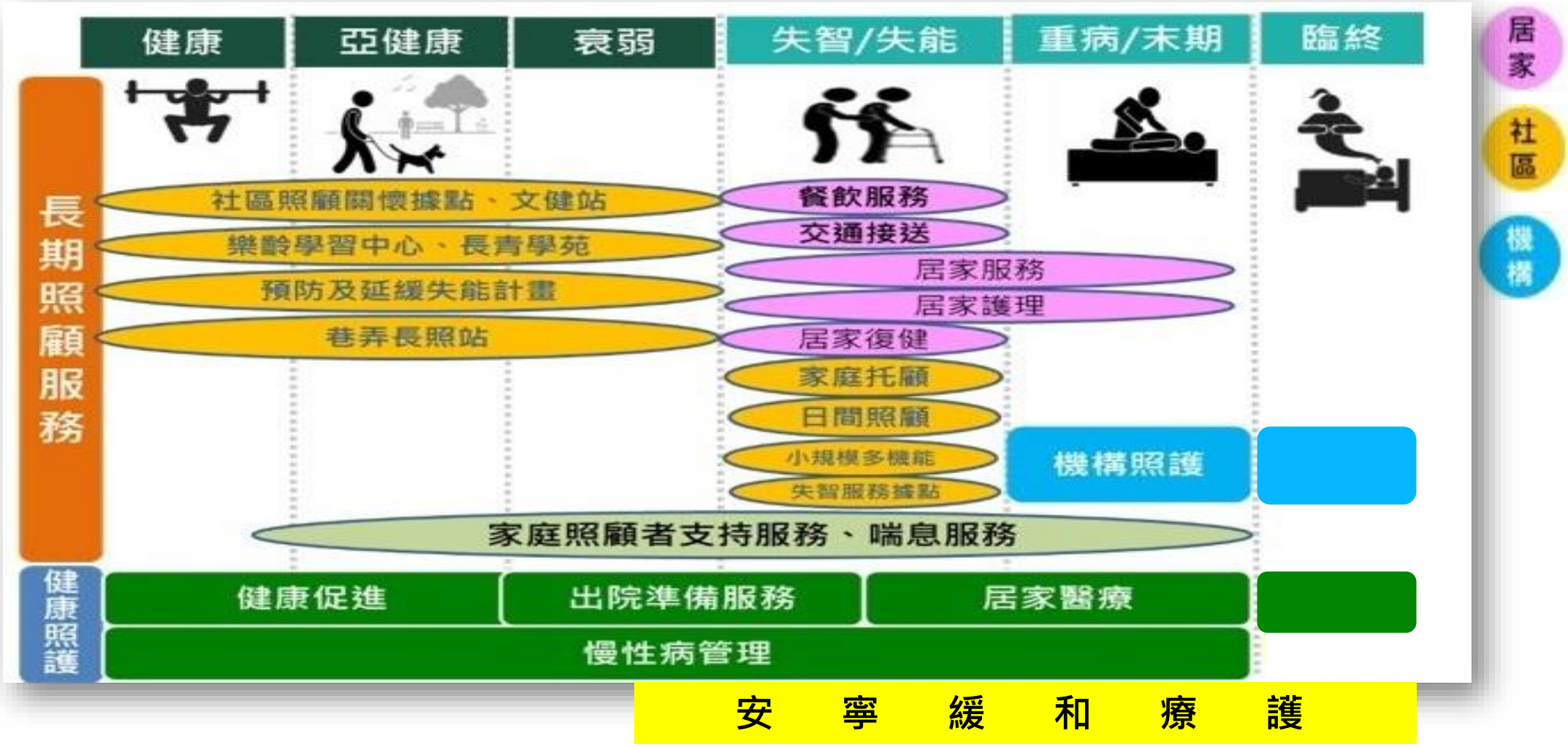
4.1 強化失智症照護服務體系

2.0 Plus版
(2026-2031)

衡量指標	2025 年 目標值	工作項目參考
4.1-5 失智症病人接受失智症安寧緩和服務的人數	失智症病人接受安寧緩和服務比率達3%	4.1-5a 安寧緩和醫療條例納入失智者需求(請參考病人自主權利法及失智症安寧緩和醫療照護指引研議) 4.1-5b 安寧療護管理列入醫院品質與評鑑 4.1-5c 將失智者使用安寧緩和服務使用率列入醫院總額專業醫療服務品質報告之指標



台灣長期照護政策圖示，2013



安寧緩和療護是失智症患者從**確診、臨終、到家屬及照護者哀慟**這**連續性照護**的核心要素。安寧緩和照護為失智症患者和照顧者提供**生理、心理、社會與靈性的支持**，包括協助**預立醫療照護諮商(ACP)**

CASCADE study-2009

重度失智病人的醫療併發症~2009 NEJM

- 追蹤22所護理之家
- 323名晚期失智症住民之臨床病程。

- 85.4%為女性。
- 年齡中位:86歲
- 調整後的中位存活期1.3年

- 研究期間，有出現以下問題的比率：
- **進食問題：85.8%**
- **發燒：52.6%**
- **肺炎：41.1%**

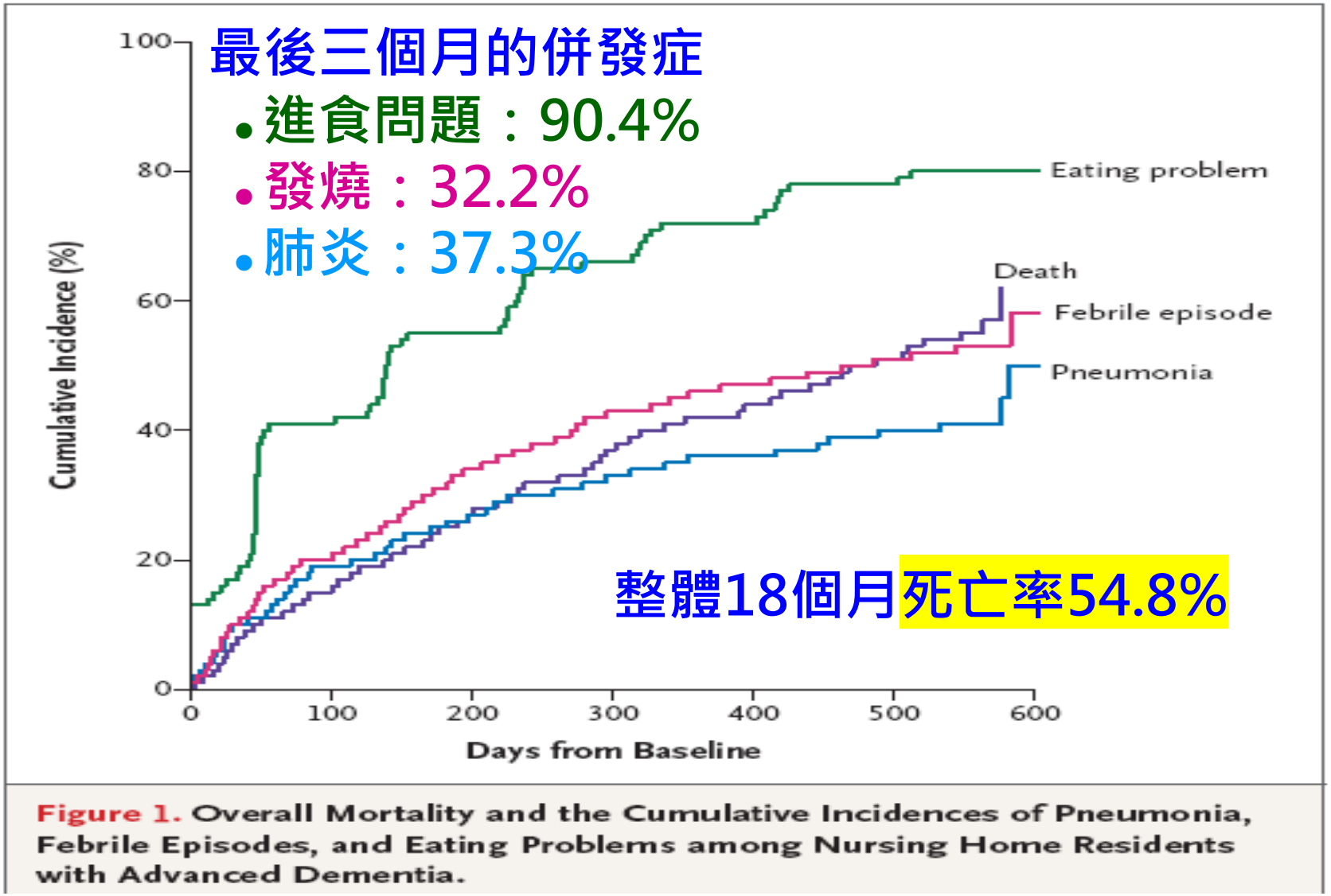
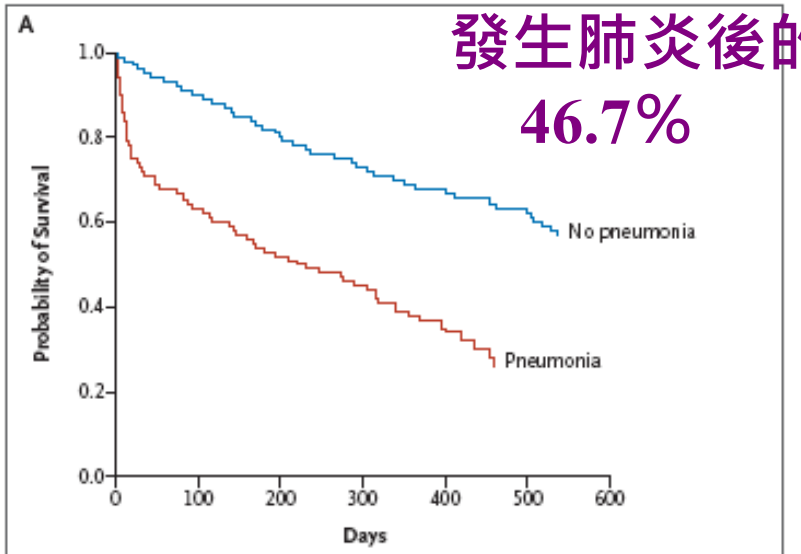


Figure 1. Overall Mortality and the Cumulative Incidences of Pneumonia, Febrile Episodes, and Eating Problems among Nursing Home Residents with Advanced Dementia.

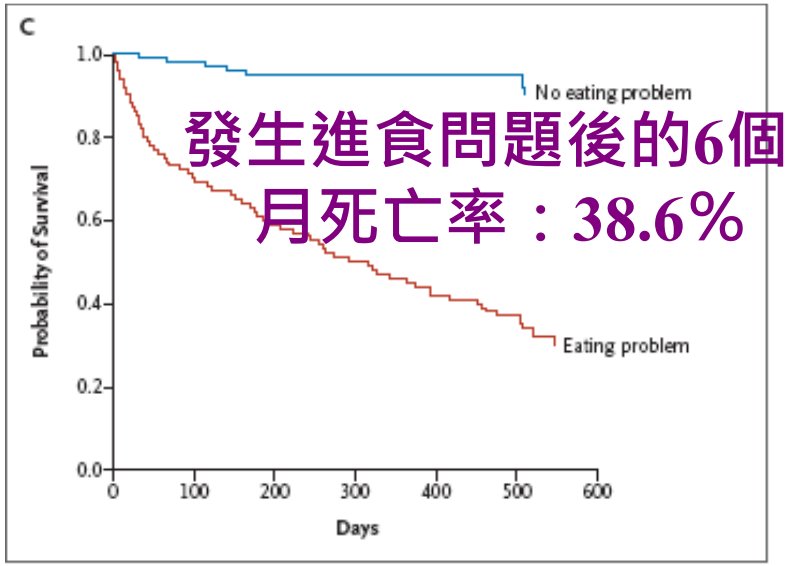
CASCADE study

校正過後的死亡率

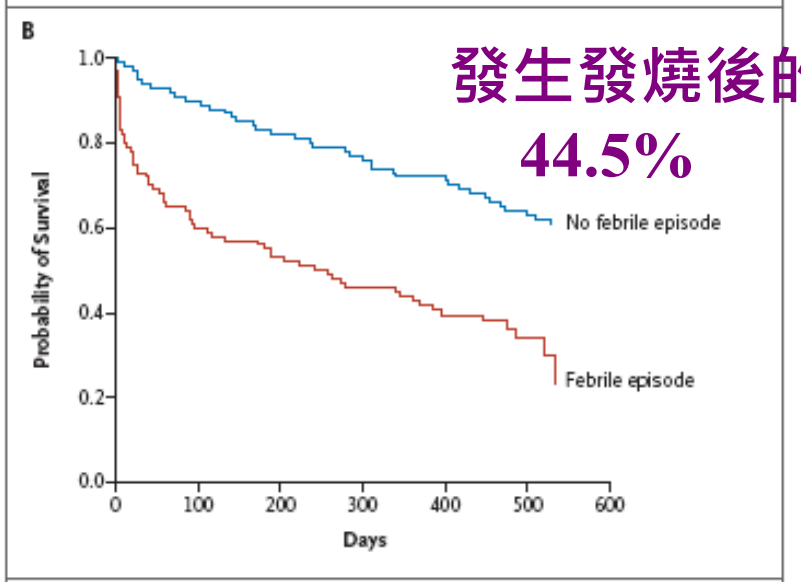
校正中位存活期：
478 days (1.3yr)
6個月死亡率：24.7%



發生肺炎後的6個月死亡率：：
46.7%



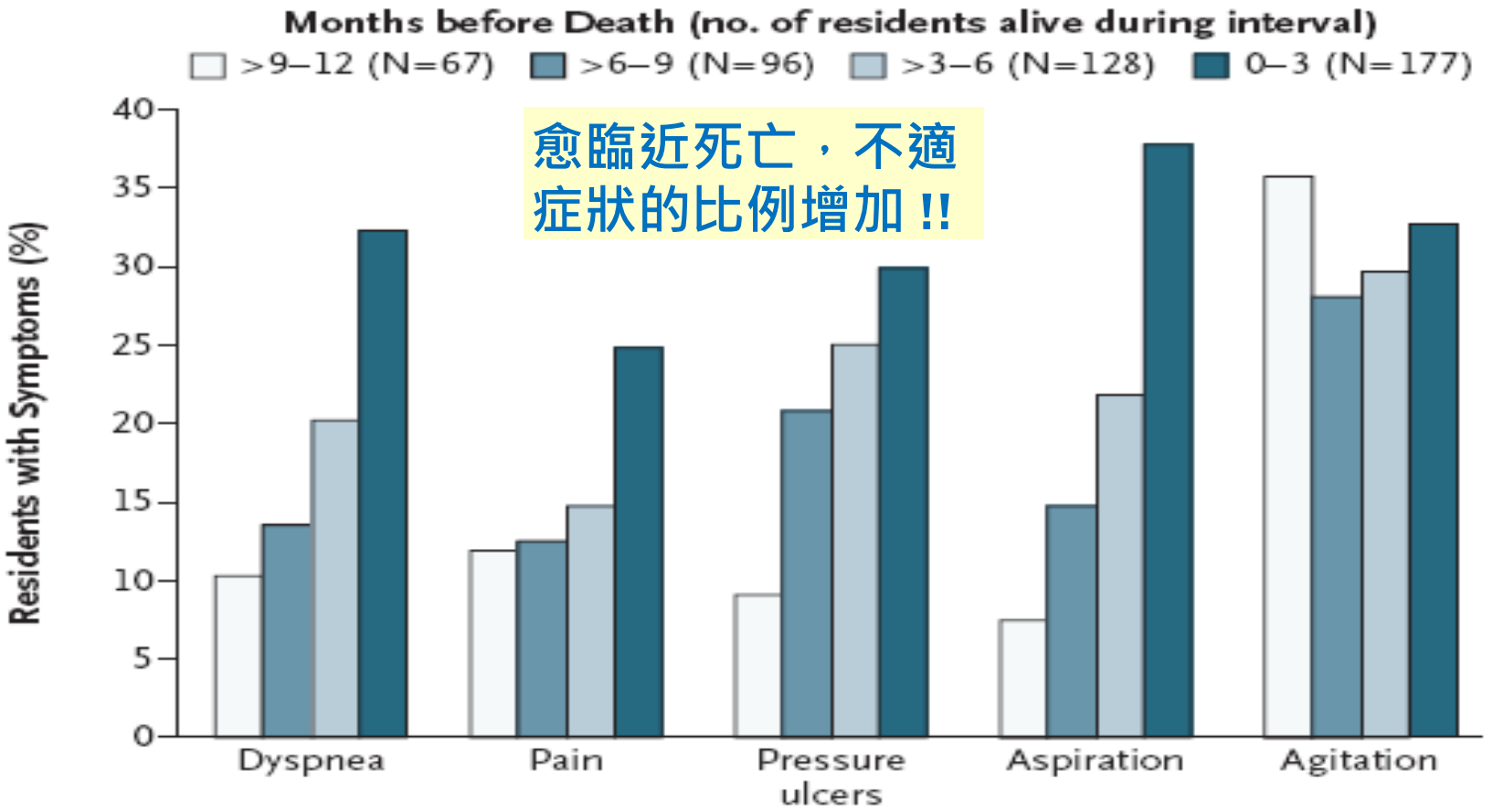
發生進食問題後的6個月死亡率：38.6%



發生發燒後的6個月死亡率：
44.5%

重度失智症病人過世前受苦症狀

【 Distressing symptoms 】



愈臨近死亡，不適症狀的比例增加 !!

追蹤18個月期間，住民痛苦症狀比例：

呼吸困難	疼痛	壓瘡	吸入性肺炎	激燥不安
46.0%	39.1%	38.7%	53.6%	40.6%

WHA 67.19
May 2014

嚴重健康相關痛苦 (SHS)
Serious Health-Related Suffering

提倡 ➔ 安寧緩和療護新定義

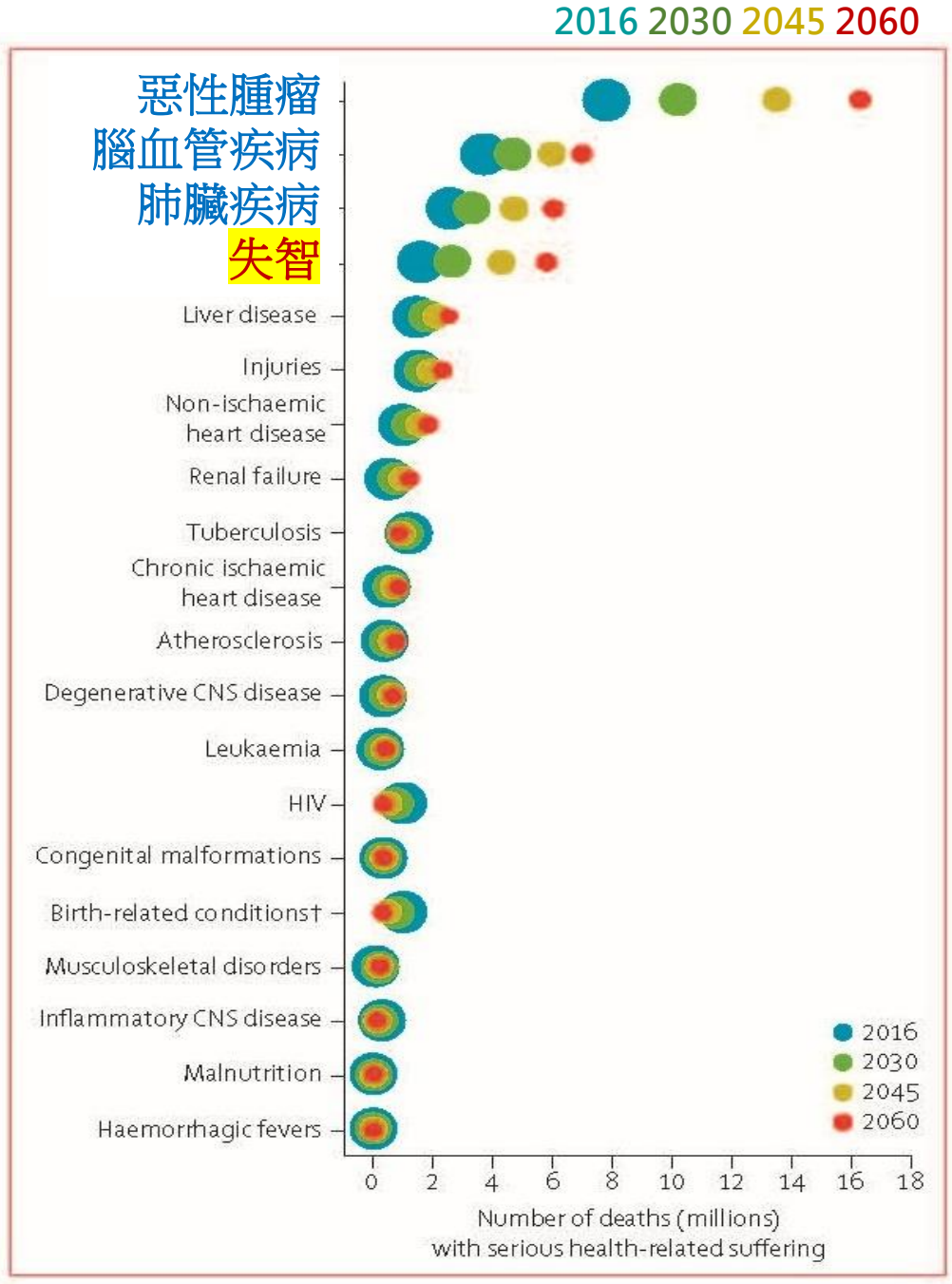
- 強調痛苦(SHS)作為新定義的核心，
- 允許從以疾病為中心的概念，進一步轉變為更加以人為中心的方法。
- 主張安寧緩和療護應根據需求而不是預後而提供，適用所有照護環境和級別，涵蓋一般和專科照護。

- WHA決議：安寧緩和療護不僅只是末期病人的需求，還應貫穿從生命早期到晚期的整個疾病過程。

導致全球嚴重健康相關痛苦的疾病負擔

- 2016~2060，全球死亡總數：從5700 萬增加到 1億以上。

- 全球緩和需求增長最快的人群：生活在**低收入國家、老年人和失智症患者。**



Sleeman, 2019

Lancet Glob Health
May 2019

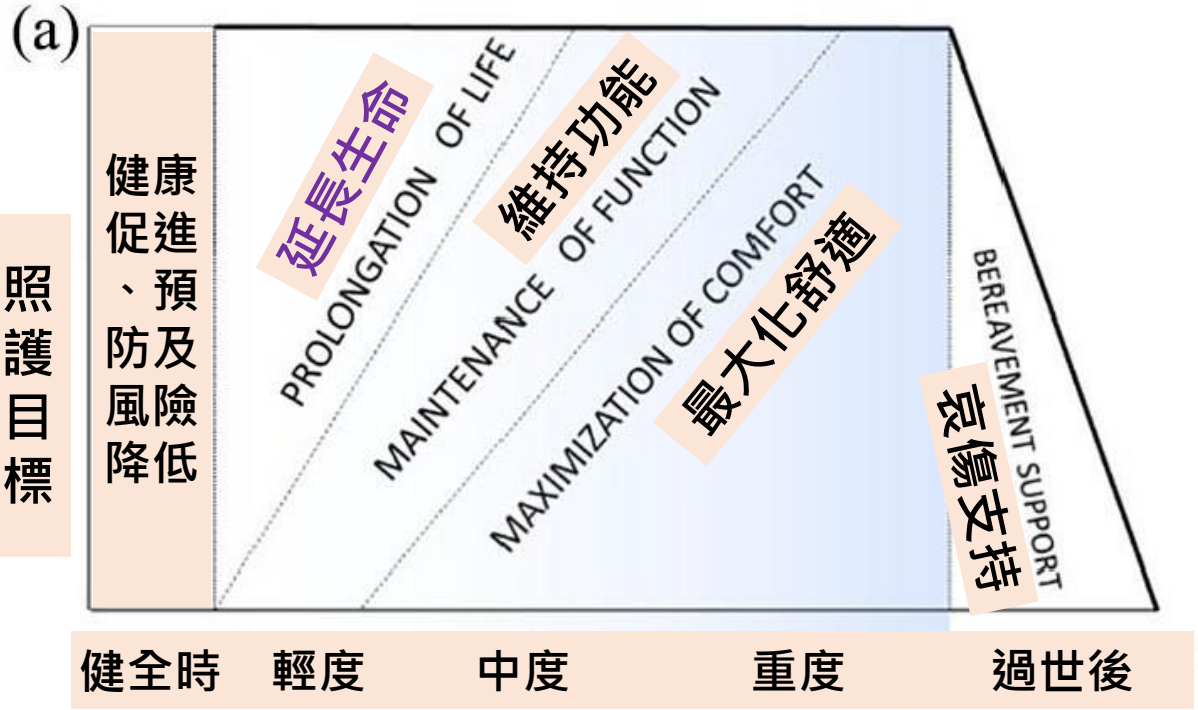
預測至2060年~全球安寧療護的未來需求

The escalating global burden of serious health-related suffering: projections to 2060 by world regions, age groups, and health conditions

Katherine E Sleeman, Maja de Brito, Simon Etkind, Kennedy Nkhoma, Ping Guo, Irene J Higginson, Barbara Gomes, Richard Harding

	ICD-10 codes used to identify number deaths	Multiplier (%)
Dementia 失智	F01–03, G30, G31	All 80% 80% 有緩和需求
Inflammatory CNS diseases	A33–35, A39, A50–53, A82, A83–86, B05, B56, B94·1, G0, G03, G04	Syphilis 70%, measles 50%, tetanus 100%, meningitis 30%, encephalitis 30%, trypanosomiasis 100%, rabies 90%
Degenerative CNS diseases	G06–12, G20–21, G23–25, G35–37, G40–41, G45–98 (except G72·1)	Parkinson's disease 65%, epilepsy 50%, multiple sclerosis 100%, other neurological conditions 65%
Cerebrovascular diseases CVA	I60–69	All 65% 65%有緩和需求
Non-ischaemic heart diseases	B57, I01–15, I30–33, I38, I40, I42	Rheumatic heart disease 65%; hypertensive heart disease 70%; cardiomyopathy, myocarditis, and endocarditis 40%; Chagas disease 30%
Chronic ischaemic heart diseases	I20–25	All 5%
Lung diseases	J30–98	COPD 80%, other respiratory diseases except asthma 50%
Liver diseases	B65, K20–K22, K28–K31, K38–K66, K70–92	Cirrhosis of the liver 95%, other digestive disease 30%, schistosomiasis 70%

失智症進展過程安寧緩和照護目標模型



2014 EAPC失智症白皮書

van der Steen JT et al., 2014

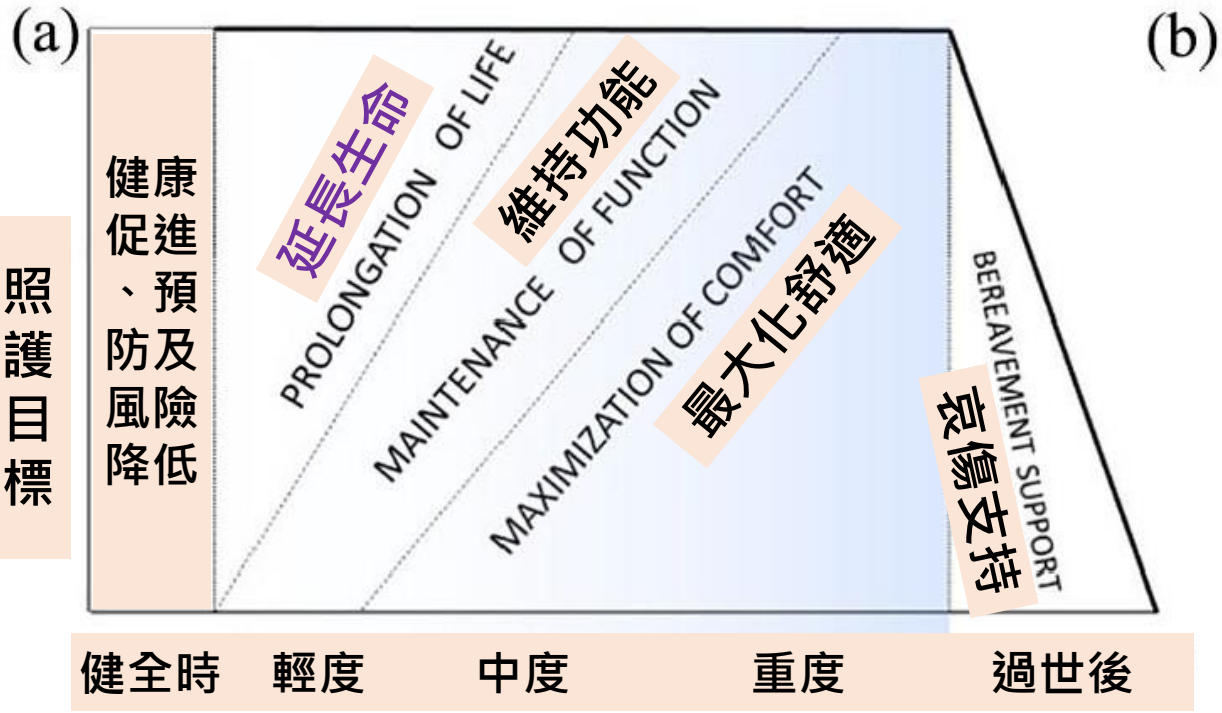
失智者臨終軌跡：

- 長尾、反覆感染、吞嚥衰退、
- 譫妄與 BPSD（行為心理症狀）

重度失智病人需要➔

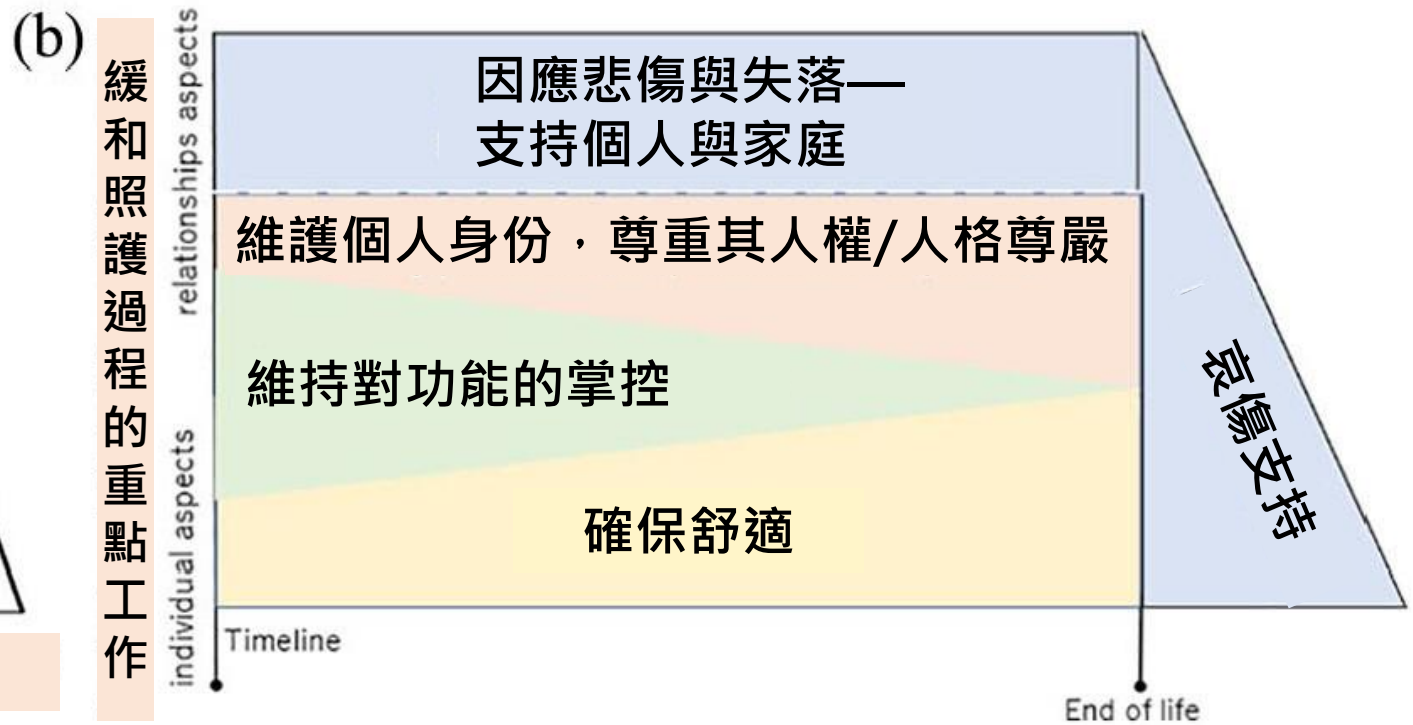
- **提早介入、連續照護、重視溝通**

失智症進展過程安寧緩和照護目標模型



2014 EAPC失智症白皮書

van der Steen JT et al., 2014



依失智患者及其家屬意見制定

Nishimura M et al., 2019,2022

日本失智症患者與家屬對最佳臨終照護的概念

首選場所

- 舒適的空間
- 理想的地點
- 可持續居住的場所
- 提供舒適照護的資源

維持人格

- 尊重原有人格特質
- 維持日常生活常態
- 與他人之關係
- 人格尊嚴

安寧善終

- 減輕造成困擾的症狀
- 自然與平靜

生命滿足

- 完成臨終心願
- 完整走完人生旅程

Nishimura, 2019

失智症患者專科安寧療護的轉診標準

JAMA Network Open
2025;8(5)

Original Investigation | Geriatrics

Referral Criteria for Specialist Palliative Care for Patients With Dementia

Yuchieh Kathryn Chang, DO; Jennifer Philip, PhD, MMed, MBBS; Jenny T. van der Steen, PhD; Lieve Van den Block, PhD, MSc; Allyn Yin Mei Hum, MD; Pedro E. Pérez-Cruz, MD, MPH; Carlos Paiva, MD, PhD; Masanori Mori, MD; Ping-Jen Chen, MD; Meera R. Agar, PhD, MPC, MBBS; Laura Hanson, MD, MPH; Catherine J. Evans, PhD, MSc, BSc; David Hui, MD, MSc

- 63 位國際專家小組成員共識➔
- 專科安寧療護的15項主要轉診標準
  - 75% 專家認為，失智症進展過程，患者被轉介至專科安寧療護的時間往往過晚。
  - 70% 專家同意，對預計存活超過2年的患者，僅出現每個主要標準就應該轉診。

JAMA Network Open. 2025

失智症患者專科安寧療護的轉診標準

基於需求(Needs-based) ➔8項

症狀困擾 (註1)

1. 嚴重身體症狀
2. 嚴重精神或存在意義的困擾
3. 嚴重情緒症狀(註2)
4. 嚴重行為或神經精神症狀(註2)

社會心理因素或決策制定

1. 要求加速死亡、協助自殺或安樂死 (註2)
2. 轉介或討論臨終照護 (註2)
3. 病人或家屬要求轉介
4. 病人和/或家屬拒絕在急性照護機構接受治療

註1：對安寧療護介入無效時

註2：可能不適用於所有國家

失智症患者專科安寧療護的轉診標準

基於疾病(Disease-based) ➔7項

失智症類型

1. 快速進展的失智症

共病症或併發症

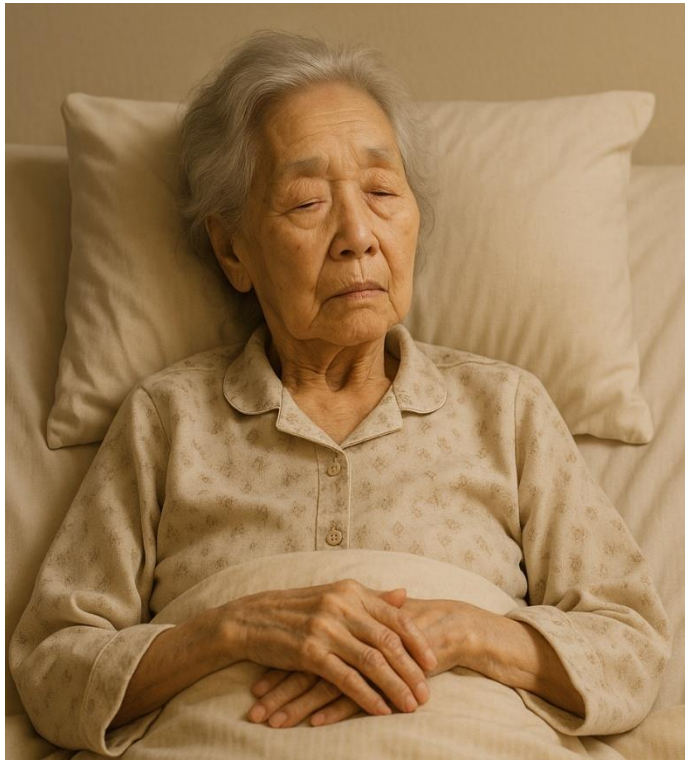
1. 病家撤回或減少延長生命的措施
2. 過去 12 個月≥2次吸入性肺炎
3. 使用人工營養(註)（如鼻胃管餵食）

入出醫院(註)

1. 過去 3 個月內 ≥1 次 ICU 入院
2. 過去 3 個月內 ≥2 次急診室就診(註)
3. 過去 3 個月內 ≥2 次住院(註)

註：針對失智症和/或相關併發症或症狀

陳老太太的治療決策?



- 89歲陳老太太，10年前喪偶，有三個孩子，大女兒是主要代理決策者。
- 阿茲海默症6年；另有高血壓、糖尿病、骨關節炎和骨質疏鬆症
- 臥床，只能說幾句話，不認得人，ADL全部依賴24小時需人照護。
- 過去半年，因為吞嚥困難，體重下降3公斤。(目前BMI約17)
- 近兩個月喝水時常會咳嗽，七個月前曾發生過一次吸入性肺炎。
- 最近2天，陳老太太持續頻繁咳嗽，出現呼吸急促和嗜睡的症狀。
- 居家醫訪的醫師診斷➔疑似吸入性肺炎。

晚期失智症照護決策專家意見比較

陳老太太的照護建議　n (%)		荷蘭 (n=26)	以色列 (n=15)
居住在家		0	10 (67)
在護理之家		26 (100)	5 (33)
人工營養和水分補充	是	0	8 (53)
(Artificial Nutrition and Hydration)	可能	2 (7)	7 (47)
	否	24 (93)	0
抗生素 (Antibiotics)	是	1 (4)	14 (93)
	可能	23 (88)	1 (7)
	否	2 (8)	0
住院 (Hospitalization)	是	0	8 (53)
	是 — 依不同地區而定	0	3 (20)
	可能	0	3 (20)
	否	26 (100)	1 (7)

Sternberg ,2021

美國、荷蘭與以色列晚期失智症照護比較

美國 (The US)	荷蘭 (Netherlands)	以色列 (Israel)
在護理之家	在護理之家(或老年精神病房)	在家 (At home)
建議入住安寧院 (Hospice)	接受安寧緩和照護 (Palliative approach)	無/或是 接受安寧緩和照護
是否接受延長生命治療每州規定不同，主要取決於病人的AD或是代理者的決定	一般不額外提供人工營養和水分補充	提供人工營養和水分補充(註2)
	可能使用抗生素(依病人利益)	可能使用抗生素 (註3)
	傳統不提供住院治療	提供住院治療
依病人AD或代理決定	醫師/家屬協商治療決策(註1)	依2005年臨終病人法決策

註1：醫師根據強烈的不施行無益治療的傳統，判斷病人最佳利益，並與家屬協商
註2：僅在生命最後兩週停止（治療），並只有在它們會加劇病人痛苦時才停止。
註3：僅在延長生命不再是目標時才停止（治療）。

Sternberg ,2021

14個國家死於失智症病人死亡地點比較

Place of Death of People Who Died From Dementia in 2008* (N = 262,993)

Country of Residence	BE	NL	ENG	WAL	FRA	ITA	ESP
Hospital	21.6	1.6	31.7	43.1	35.9	32.1	33.6
Home	11.2	3.8	5.0	4.2	27.2	42.2	46.1
LTC setting	66.7	93.1	61.7	48.9	34.0	19.5	20.1
Palliative care institution	—	—	0.1	0.1	—	—	—
Other	0.5	1.5‡	1.5	3.7	2.9	6.2	0.2

Country of Residence	HUN†	CZR	NZE	USA	CAN	MEX	KOR
Hospital	62.3	27.5	14.3	13.2	32.3	26.2	73.6
Home	—	10.6	4.5	15.3	3.4	69.3	20.5
LTC setting	—	61.5	76.6	62.6	59.4	—	5.5
Palliative care institution	—	—	0.3	2.9	—	—	—
Other	37.7	0.4	4.4	6.0	4.9	4.5	0.4

Reyniers T. et al. 2015

被低估的痛點：失智症末期的照護盲點

The Dementia Blindspot

12.95人 / 每10萬人

（2020年失智症死亡率，顯著攀升）

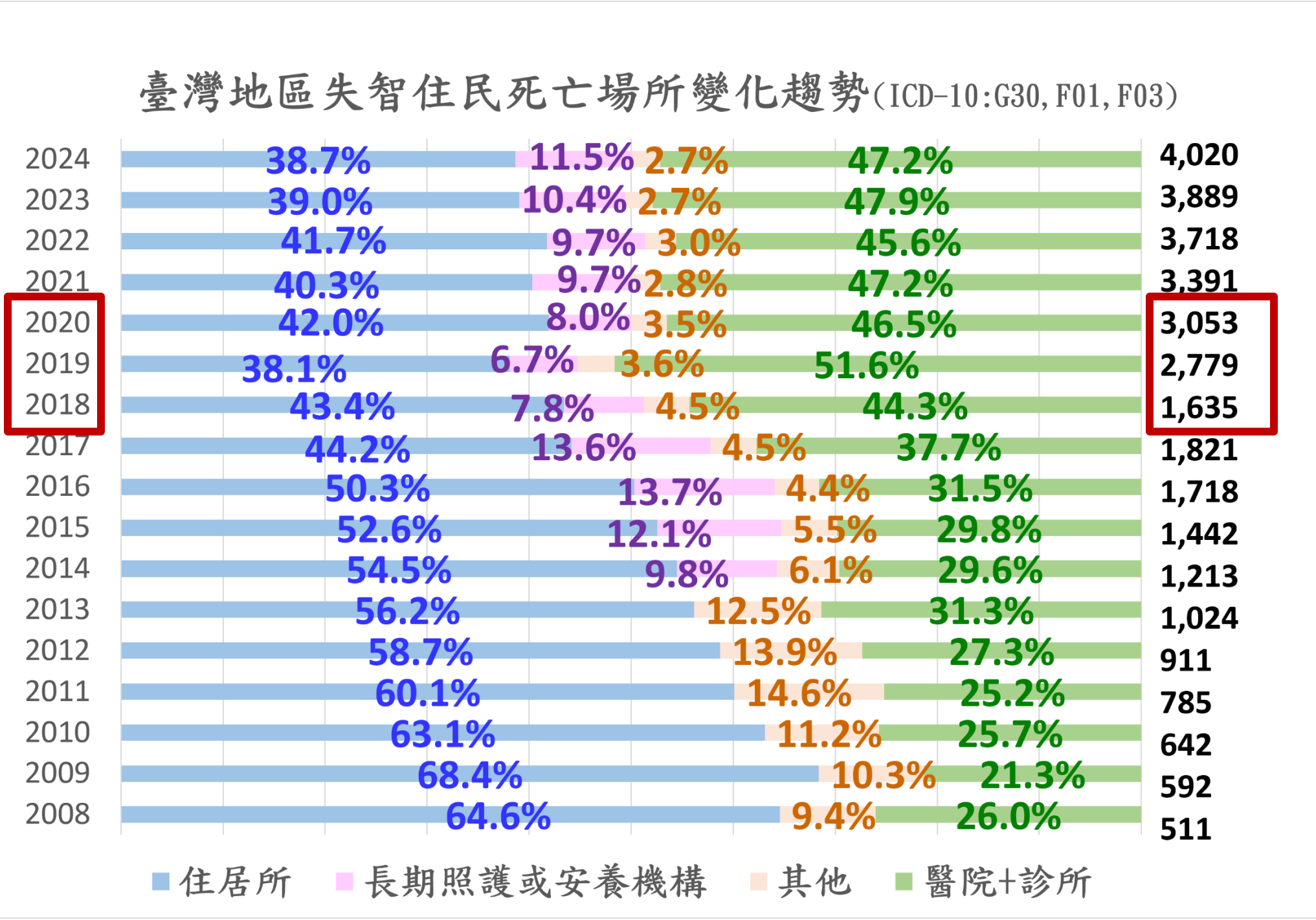
- 死因常被低估（易被錯歸類為肺炎）
- 在家死亡率已降至 42.0%
- 機構內死亡率異常偏低（<10%）



若未正確認列失智症末期照護需求，
政策與資源配置將持續低估這群病人的真實需要。

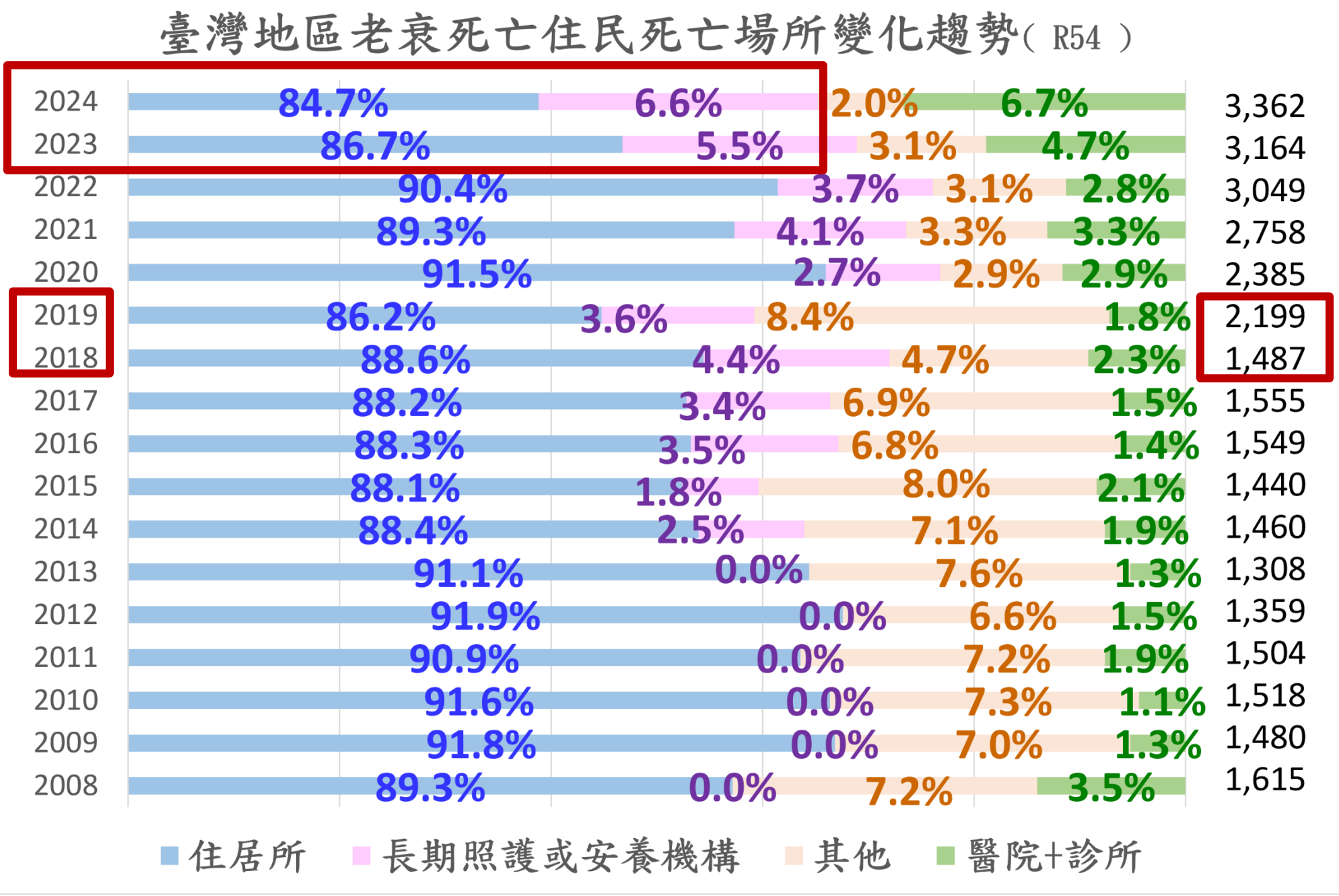
2019年更換死因選碼系統，原死於肺炎、腦血管疾病或其他併發症者被改選為失智死因。

臺灣失智病人在家過世的比例自2018起減少，在長照機構過世的比例較其他國家為低。



2022/06，擴大安寧療護對象納入末期衰弱老人

2019年更換死因選碼系統，原其他死因者被改選為老衰死因。



善終

不可以少預
立醫療決定

如果可以選擇，
希望自己的生命終點～



在醫院
過世!



在急診
過世!



在自宅
過世!



在機構
過世!

臨終彌留返家

在榮民體系社區、榮家、醫院推展安寧緩和療護的步驟

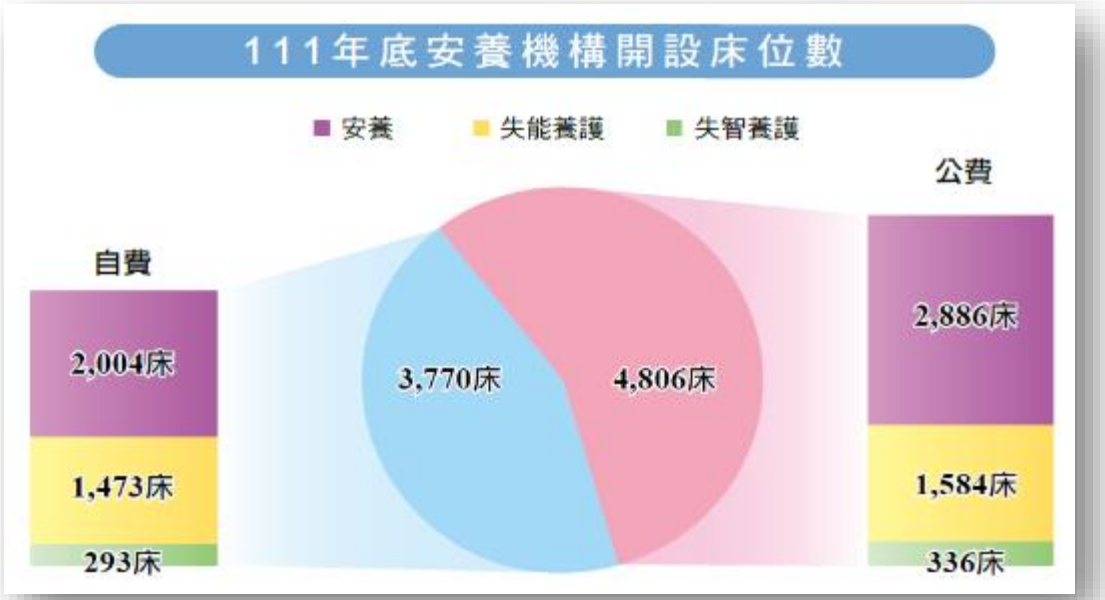


針對工作團隊與照服員安排教育訓練

全臺灣最大的長照體系
退輔會：榮民之家



- 三級醫療
- 專業人力
- 照護經驗
- 資源連結



現有榮民 48%為 65 歲以上高齡榮民
老年榮民佔全國老人比例約佔 4.9%

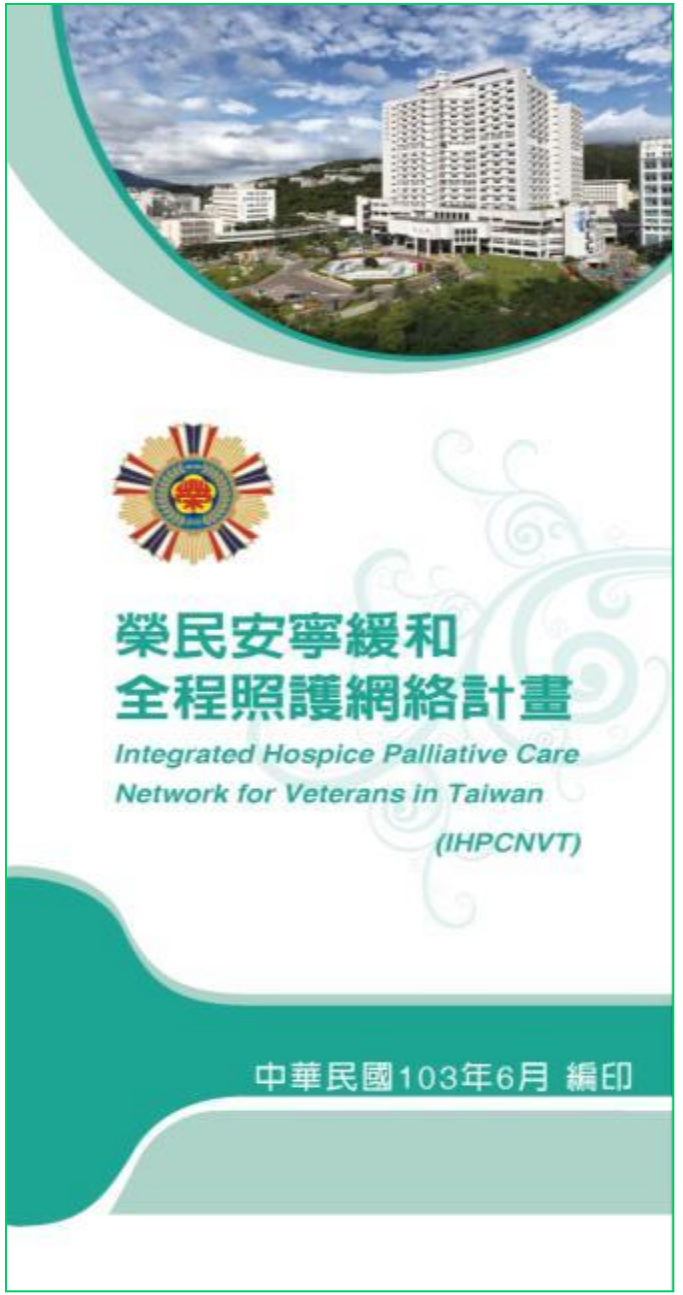
榮民體系安寧緩和
全程照護網絡

SINCE 2014

榮民安寧全程照護網絡

親切、安寧、連繫

Integrated Hospice Palliative Care Network for Veterans



榮民體系安寧緩和療護服務概況

	醫學中心	區域醫院	社區醫院
全國安寧床數	245床	400床	228床
退輔體系開設安寧病房醫院數及安寧床數	3家總院 54床	桃園、嘉義 2家分院25床	新竹、埔里、臺東、玉里、蘇澳、臺南等 6家分院及關渡醫院 63床
退輔體系開設安寧病房占比例%	22.0%	6.3%	27.6%

- 至2024年7月止，全國安寧病房共86家，873床，榮民體系醫院共提供16.2%之安寧床位(142床)；
- 130家醫院開辦安寧居家服務；榮民醫院佔12.3%。
- 168家醫院開辦住院病人安寧共同照護服務，榮民醫院佔10.1%。





針對榮家/全國分院第一線工作人員
辦理安寧緩和療護實務課程

榮家工作人員10小時安寧緩和療護實務課程

課程主題	時數	進行方式
發掘機構中適合安寧療護的病人	2	以榮家的案例為基礎說明安寧療護介入時機 同時提供五個標準教案分組演練及案例討論： 1.發現病人-運用 SPICT 篩檢量表 2.如何支持哀傷的照護者 3.反覆說” 救救我”病人的心靈需求 4.總是說” 沒有意義”病人的心靈需求 5.當病人說” 我快死了”時的臨床處遇
末期病人常見的心理社會靈性需求與處置	2	
瀕死症狀評估與護理遺體護理	2	建議以分組實務操作或跑檯的方式進行: 第 I 站 皮膚照護 第 II 站 水腫照護 第 III 站 腸胃症狀 第 IV 站 口腔護理 第 V 站 呼吸照護 第 VI 站 瀕死症狀
末期症狀照護與實務操作	4	

(輔導員僅需上前4小時課程)

辨識

有緩和療護照護需求民眾的辨識

SPICT-TW

SPICT–TW™

Supportive and Palliative Care Indicators Tool (Taiwan)

1. SPICT-TW使用的核心目標
   - 是當個人整體健康狀況有變動、出現健康惡化加速的風險，或是照護與支持的需求增加時，**能幫助及時辨識並評估緩和療護的需求**，方便討論合適的照顧計畫
   - 協調溝通社區或醫院中跨領域不同專業的醫療或相關照護人員。

https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-tw-taiwan/

支持性及緩和療護指標工具 – 2022臺灣版 (SPICT-TW)

SPICT 支持性及緩和療護指標工具是一份指南，可以用來辨識健康狀況正在惡化的病人，協助評估了解這些病人是否有未被滿足的支持性及緩和療護需求，並擬定照護計畫。

第一步驟：尋找健康狀況正在惡化的一般性指標	
□	非預期性的(多次)住院。
□	日常功能狀況不佳或持續惡化（例如一半以上時間臥床或限制於椅子上），且回復的可能性不高。
□	因為生理或心理的健康問題，需要依賴他人的照顧。
□	病人的照護者需要更多的協助與支持。
□	持續的體重減輕; 或本身體重就過輕; 或肌肉量過低。
□	儘管原有疾病已接受最佳治療，病人仍持續出現不適症狀。
□	病人（或家屬）要求緩和醫療; 或是病人要求減少、停止或不進行治療; 或希望醫療聚焦在生活品質。

第二步驟：針對下列一個或多個威脅生命的重大疾病，篩選病人是否符合特定臨床指標			
癌症	□ 因癌症持續進展而導致日常功能惡化。 □ 因太衰弱而無法接受抗癌治療，或治療目標已轉為症狀控制。	**心血管疾病**	□ 心衰竭或有嚴重難以治療的冠狀動脈疾病; 在休息或少量活動時，仍出現呼吸困難和胸痛。 □ 罹患嚴重無法手術的週邊血管疾病。
失智症/衰弱	□ 在無人幫助下，無法自行穿衣、行走或進食。 □ 進食喝水減少; 吞嚥出現困難。 □ 出現尿失禁或排便失禁。 □ 無法透過口語來表達溝通; 社交互動極少。 □ 經常跌倒; 大腿骨骨折。 □ 反覆發燒或感染; 吸入性肺炎。	**呼吸道疾病**	□ 嚴重慢性肺臟疾病; 在休息或少量活動時，仍出現呼吸困難。 □ 持續低血氧而需要長時間的氧氣治療。 □ 因呼吸衰竭需要呼吸器治療，或不適合使用呼吸器治療。

神經性疾病	□ 儘管已提供最佳治療，仍出現身體及(或)認知功能的持續惡化。 □ 語言障礙導致嚴重溝通困難，及(或)愈來愈嚴重的吞嚥困難。 □ 反覆發生吸入性肺炎; 呼吸困難或呼吸衰竭。 □ 中風後持續癱瘓使得生理功能明顯喪失且持續失能。	**腎臟疾病**	□ 慢性腎臟病第四或五期(即腎絲球過濾率 eGFR 小於 30ml/min)，健康狀況正惡化中。 □ 腎衰竭導致其他威脅生命的病況或治療更加複雜。 □ 停止或不打算開始腎臟透析治療的病人。
其他	□ 病情惡化且合併其他病況; 不可逆的多重病況或併發症；現行可用的最佳治療方式其癒後都不佳。	**肝臟疾病**	□肝硬化，在過去這一年當中出現下列一項以上的併發症：1)對利尿劑治療無效的頑固性腹水，2)肝腦病變，3)肝腎症候群，4)細菌性腹膜炎，5)反覆的食道靜脈出血。 □ 無法進行肝臟移植的病人。
第三步驟：回顧檢視目前的照護內容與照護計畫			
□ 檢視目前接受的治療及藥物，確認病人已接受最佳照護；盡可能減少多重用藥。		□ 假設症狀或問題是複雜難以處理的，須考慮轉介安寧緩和專科醫療人員進一步評估。	
□ 與病人、家屬或其他親近的人，針對現在與未來的照護計畫達成共識，並支持照顧者。		□ 若病人有喪失自主決策之心智能力的可能，更應儘早開始討論照護計劃。	
□ 紀錄、分享並回顧檢視照護計畫之內容。			

溝通

辦理榮民體系緩和家庭會議溝通工作坊



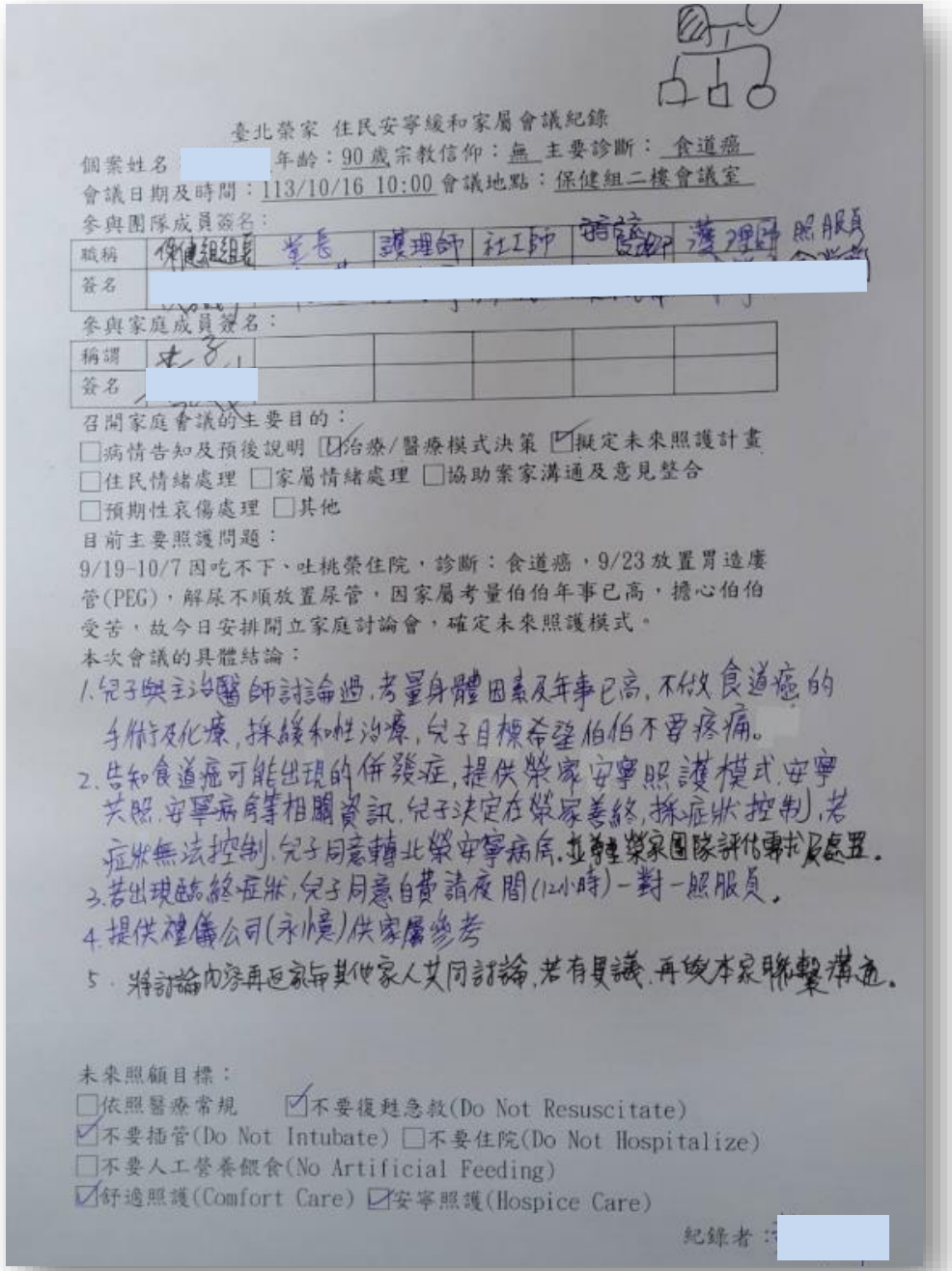
2021.10.28 - 10.29





榮總ACP團隊至榮民之家進行預立醫療照護諮商

居家團隊至機構協助緩和醫療家庭諮詢會議



臺北榮家 住民安寧緩和家屬會議紀錄

個案姓名：[redacted] 年齡：90歲 宗教信仰：無 主要診斷：食道癌

會議日期及時間：113/10/16 10:00 會議地點：保健組二樓會議室

參與團隊成員簽名：

職稱	保健組組長	業長	護理師	社工師	諮商師	藥理師	照服員
簽名	[redacted]						

參與家庭成員簽名：

稱謂	兒子					
簽名	[redacted]					

召開家庭會議的主要目的：

☐病情告知及預後說明 ☑治療/醫療模式決策 ☑擬定未來照護計畫

☐住民情緒處理 ☐家屬情緒處理 ☐協助案家溝通及意見整合

☐預期性哀傷處理 ☐其他

目前主要照護問題：

9/19-10/7 因吃不下、吐桃榮住院，診斷：食道癌，9/23 放置胃造廔管(PEG)，解尿不順放置尿管，因家屬考量伯伯年事已高，擔心伯伯受苦，故今日安排開立家庭討論會，確定未來照護模式。

本次會議的具體結論：

1. 兒子與主治醫師討論過，考量身體因素及年事已高，不做食道癌的手術及化療，採緩和性治療，兒子目標希望伯伯不要疼痛。
2. 告知食道癌可能出現的併發症，提供榮家安寧照護模式、安寧共照、安寧病房等相關資訊，兒子決定在榮家善終，採症狀控制，若症狀無法控制，兒子同意轉北榮安寧病房，並聯繫榮家團隊評估專業處置。
3. 若出現臨終症狀，兒子同意自費請夜間(12小時)一對一照服員。
4. 提供禮儀公司(永懷)供家屬參考
5. 將討論內容再回家與其他家人共同討論，若有異議，再與本家聯繫溝通。

未來照顧目標：

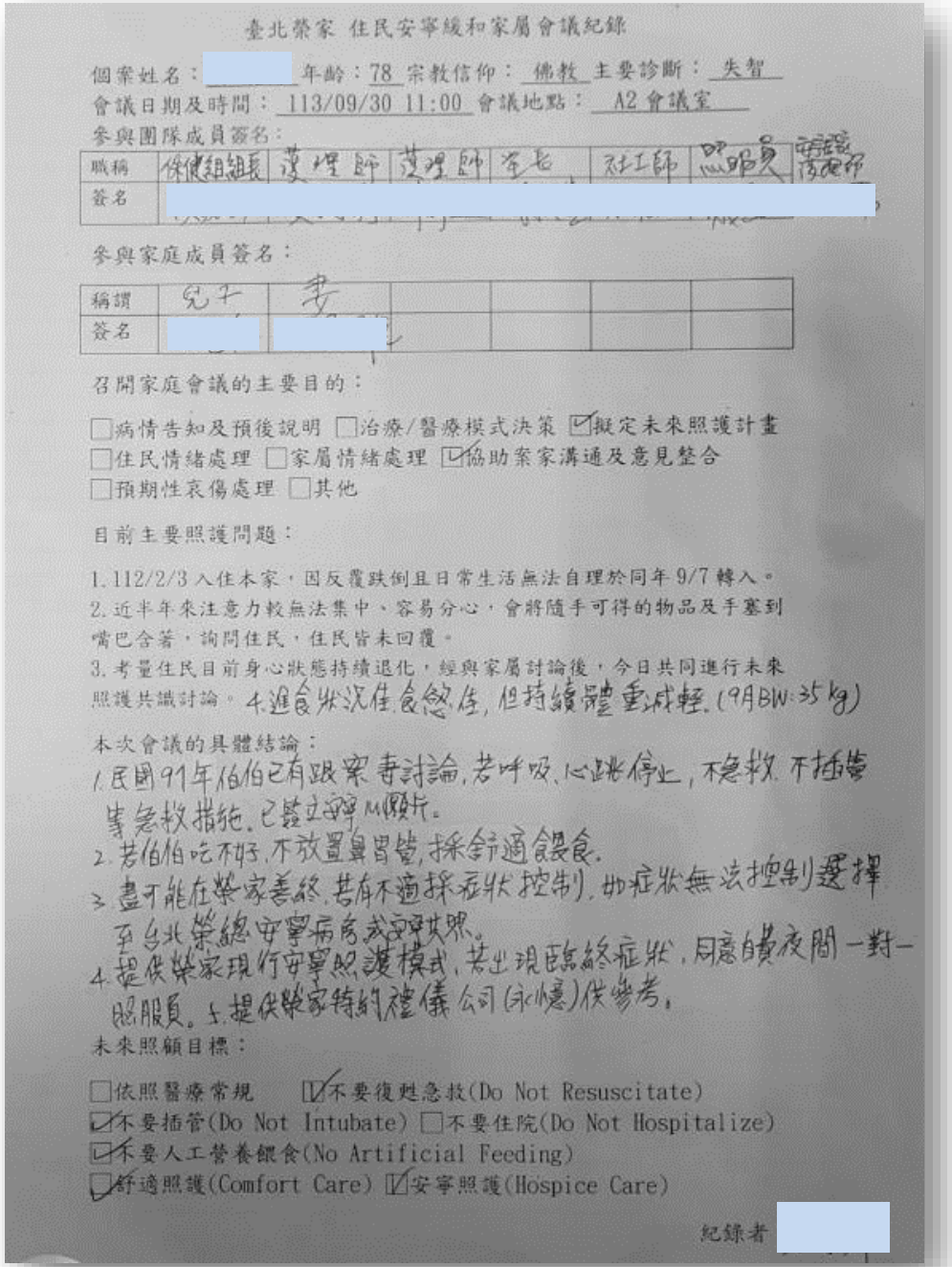
☐依照醫療常規 ☑不要復甦急救(Do Not Resuscitate)

☑不要插管(Do Not Intubate) ☐不要住院(Do Not Hospitalize)

☐不要人工營養餵食(No Artificial Feeding)

☑舒適照護(Comfort Care) ☑安寧照護(Hospice Care)

紀錄者：[redacted]



臺北榮家 住民安寧緩和家屬會議紀錄

個案姓名：[redacted] 年齡：78 宗教信仰：佛教 主要診斷：失智

會議日期及時間：113/09/30 11:00 會議地點：A2 會議室

參與團隊成員簽名：

職稱	保健組組長	護理師	藥理師	業長	社工師	照服員	諮商師
簽名	[redacted]						

參與家庭成員簽名：

稱謂	兒子	妻				
簽名	[redacted]	[redacted]				

召開家庭會議的主要目的：

☐病情告知及預後說明 ☐治療/醫療模式決策 ☑擬定未來照護計畫

☐住民情緒處理 ☐家屬情緒處理 ☑協助案家溝通及意見整合

☐預期性哀傷處理 ☐其他

目前主要照護問題：

1. 112/2/3 入住本家，因反覆跌倒且日常生活無法自理於同年 9/7 轉入。
2. 近半年來注意力較無法集中、容易分心，會將隨手可得的物品及手塞到嘴巴含著，詢問住民，住民皆未回覆。
3. 考量住民目前身心狀態持續退化，經與家屬討論後，今日共同進行未來照護共識討論。4.進食狀況佳食慾佳，但持續體重減輕.(9月BW:35 kg)

本次會議的具體結論：

1. 民國91年伯伯已有跟案毒討論，若呼吸、心跳停止，不急救、不插管等急救指施。已簽立安寧意願書。
2. 若伯伯吃不好，不放置鼻胃管，採舒適餵食。
3. 盡可能在榮家善終，若有不適採症狀控制，如症狀無法控制選擇至台北榮總安寧病房或安寧共照。
4. 提供榮家現行安寧照護模式，若出現臨終症狀，同意自費夜間一對一照服員。5.提供榮家特約禮儀公司(永懷)供參考。

未來照顧目標：

☐依照醫療常規 ☑不要復甦急救(Do Not Resuscitate)

☑不要插管(Do Not Intubate) ☐不要住院(Do Not Hospitalize)

☑不要人工營養餵食(No Artificial Feeding)

☑舒適照護(Comfort Care) ☑安寧照護(Hospice Care)

紀錄者：[redacted]

臺灣健保給付緩和醫療家庭諮詢費(2250點)

02020B
(2015.02~)

- 以現行住院或急診重症病人，且已進入末期狀態者為主。
- 每人每院限申報二次。

P5407C
(2016.02~)

- 限居家整合計畫之S3重度居家醫療階段申報。
- 以進入末期狀態病人為主。
- 同一照護團隊對同一照護對象限申報二次。

- 諮詢參與人員：包括主治醫療團隊、病人或病人家屬。
- 每一個案諮詢時間至少1小時。
- 應有完整的諮詢記錄留存，並有參與諮詢團隊及病家簽名
- 另已參與全民健康保險安寧共同照護試辦方案、住院安寧療護及居家安寧照護後，不得再申報。

緩和家庭會議溝通甚麼?

餵食策略

- Comfort Feeding（細心手餵)、
- 鼻胃管灌?

症狀照護

- 呼吸、疼痛、煩躁譫妄
- 便秘/尿滯留、
- 口腔/皮膚照護、分泌物

感染處理

- 住院治療？
- 針劑/口服抗生素？
- 舒適為主 vs 延命治療

臨終決策

- 死亡場所討論與紀錄
- DNR / POLST
- comfort kit
- Deprescribing

引入國際機構住民資料包含照護偏好

Advance Directives/Goals of Care

☐ Full Code ☐ DNR (Do Not Resuscitate) ☐ DNI (Do Not Intubate)

☐ DNH (Do Not Hospitalize) ☐ No Artificial Feeding

☐ Comfort Care ☐ Hospice Care

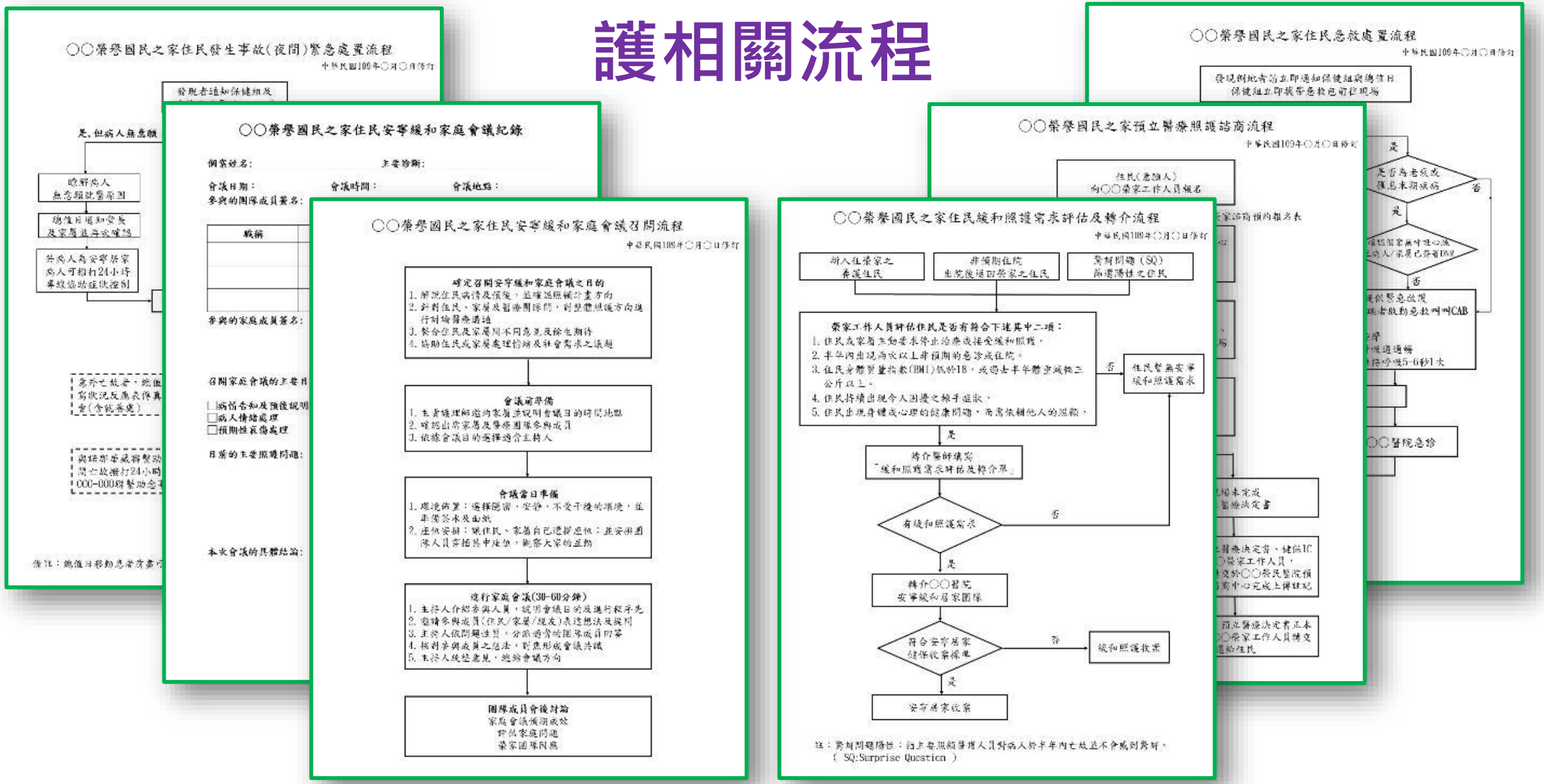
☐ Other *(specify)*: _____

Were goals of care discussed during this hospitalization? ☐ No ☐ Yes *(specify)*

Full Code	依照醫療常規
DNR (Do Not Resuscitate)	不要復甦急救
DNI (Do Not Intubate)	不要插管
DNH (Do Not Hospitalize)	不要住院
No Artificial Feeding	不要人工營養餵食
Comfort Care	舒適照護
Hospice Care	安寧照護

準備

榮家安寧緩和照護相關流程



安寧居家舒適照護箱



臺北榮民總醫院舒適處方

病人姓名：_____ 開立日期：_____ 醫師簽章：_____

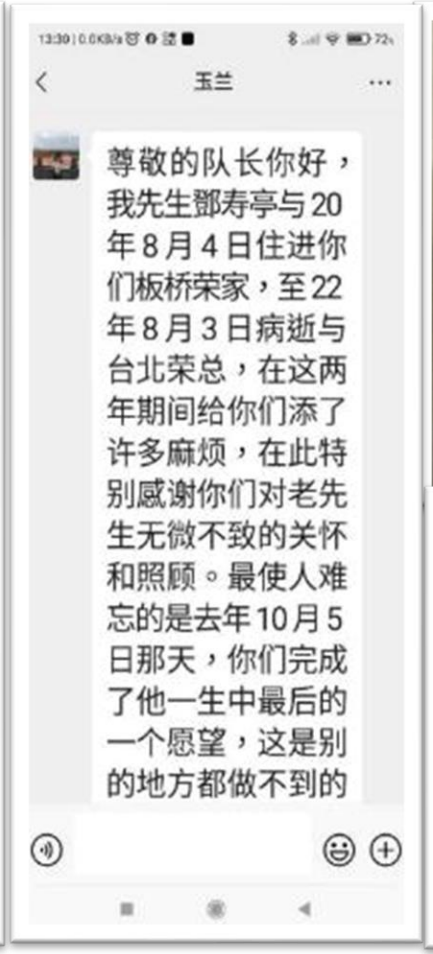
	處方藥物 (請勾選☑ 表示開立處方)	使用方法
發燒	☐ Acetaminophen (500 mg); p.o. ☐Cataflam (25mg); p.o ☐Diclofenic (12.5mg) supp.	耳溫大於____度，每___小時使用一顆
疼痛 喘 呼吸困難	☐Morphine (15mg);p.o. ____ mg	需要時每___小時使用口服 _____mg 無法口服時，可磨粉放舌下
	☐Fentanyl patch 12ug /片	每三天更換一片
	☐Painkyl buccal film 200 mcg/片	需要時每 6 小時貼於濕潤口腔黏膜內
	☐ Dexamethasone (5mg/ml/amp)	需要時每____可皮下注射_____ml
口水分泌物多 死亡嘎嘎聲	☐*Scopolamine 1.5mg/片	貼於耳後，每次一片，可使用三天
便祕	☐* Bisacodyl supp. (10mg)	若三天未排便可每次使用 1 粒.
噁心感	☐ Haloperidol (5mg);p.o.	需要時每___小時口服 0.5~1 顆
	☐ Binin-U (5mg/ml/amp);SC	需要時___小時皮下 0.2ml, 或持續皮下 0.5-1ml/day
	☐ Olanzapine (10mg); p.o. (Zyprexa®)	需要時每日口服 0.5~1 顆
	☐ Dexamethasone (5mg/ml/amp)	需要時每日皮下注射_____ml
煩躁不安 瞻妄 失眠	☐Risperidone (1mg/ml) (Risperidal®)	需要時每_____小時口服_____ cc
	☐ Binin-U (5mg/ml/amp);SC	視需要每_____小時皮下 0.2ml, 或持續皮下 0.5-1ml/day
	☐Haloperidol (5mg) (Haldol®)	需要時每____小時口服 0.5~1 顆
	☐Lorazepam (0.5mg)(Ativan®)	需要時每____小時口服 0.5~1 顆
	☐Midazolam (7.5 mg)(Dormicum®)	需要時每____小時口服 0.5~1 顆
	☐Midazolam(1mg/ml, 5ml/amp)(Dormicum®)	需要時每____小時皮下 2.5ml, 或持續皮下 10ml/day
癲癇 肌陣攣	☐Midazolam(1mg/ml, 5ml/amp)(Dormicum®)	需要時每_____小時皮下 2.5ml, 或持續皮下 10ml/day
	☐Clonazepam (0.5mg) (Rivotril®) ☐Diazepam (2mg) (Valium®)	需要時每____小時口服 0.5~1 顆
急性心絞痛	☐Nitrostat 0.4mg 舌下錠	需要時舌下含服每次使用 1 錠，每五分鐘使用 1 錠最多 3 錠。

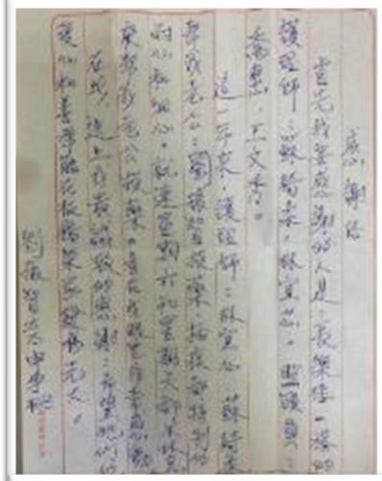
支持

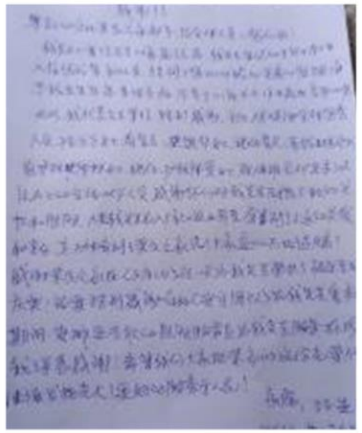
善用線上群組提供全天候善終服務













安寧居家訪視支持住民維持理想的生活品質













新竹分院
多元族群
善終在地
茶花朵朵開



新竹榮家
送愛遠行-
學習面對死亡
的照護課題



雲林榮家
自立樂齡肌智
賦能在家老化
-雲榮心家園



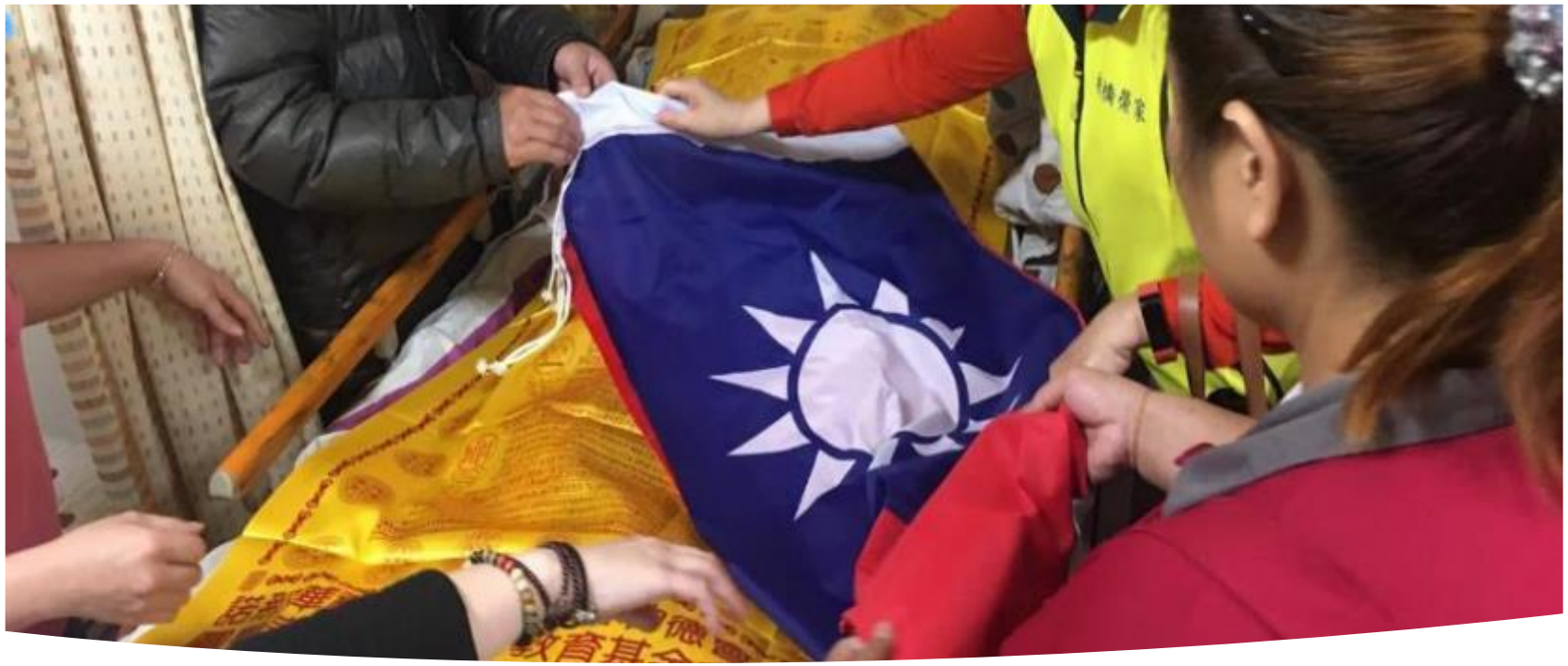
板橋榮家
透過機構安寧
照護許老榮民
圓滿善終之路

安寧緩和療護獲得SNQ國家品質標章肯定

在自己的家 尊嚴善終



板橋榮家居家安寧



榮家安寧緩和療護影片

https://www.youtube.com/watch?v=9Li12M6ongY

失智者的安寧緩和照護實踐

（American Academy of Family Physicians, 2022）

美國家庭醫師學會指引

症狀管理
非藥物介入

強調預立醫
療照護計畫

跨團隊合作
照護者支持

Advance Care Plan

晚期失智症安寧療護指引

病程不確定性。存活預測極具挑戰

整合安寧療護

- 複雜醫療需求。
- **避免過度治療。**

症狀評估與監測

- 晚期繁重症狀。
- 監測品質確保舒適。

非藥物介入策略

- 滿足社會心理需求。
- **以人為本**的照護。

治療決策參與

- 反覆治療決策討論。
- 重要相關者共同討論。

預立醫療計劃

- 確保舒適照護。
- **避免臨終前過度介入。**

家屬支持系統

- 持續支持/代理決策支援。
- 協助瞭解臨終過程。

照護場所現況

- 長照機構與醫院是常見死亡場所。
- 長照機構應提供優質安寧療護，**避免不必要轉院**。

跨專業合作

- 應促進精神科醫師、老年醫學專家、**家庭醫師與安寧團隊間的跨領域協作。**

需要醫療團隊、患者家屬與照護機構的密切配合，以提供優質臨終關懷。



第一篇 需求評估、收案時機、存活期預估

1.失智緩和需求及收案時機

2.失智症生命末期存活預估

第二篇 症狀與處置、不同場域照護與人員訓練

3. 症狀評估處置

4.急性醫院

5.長照機構

6.社區與居家照護

7.晚期個案吞嚥評估處置

8.中醫在醫療照護的角色

第三篇 預立醫療自主計畫(ACP)

9.認知障礙者的ACP/AD

10.失智症病人ACP實例

第四篇 照護者之復原力(Resilience)及身心支持

11.照護者之復原力(Resilience)及身心壓力之支持

第五篇 失智症末期照護之倫理與法律相關議題

12.末期醫療照護之倫理與法律相關議題

Royal College of Physicians

RCP position statement on palliative and end-of-life care

70%的人死於病程可預測的疾病。然而，許多臨終病人卻在急診或醫院走廊接受照顧——這些環境並不適合提供體貼、有尊嚴的照護。

英國皇家醫師學會　08/08/25

失能等級FAST（功能評估分級量表）

分期	期別名稱	期別特徵 (Functional Assessment Staging)
1	正常老化	完全無缺損
2	可能輕度認知障礙	主觀功能缺損
3	輕度認知障礙	客觀功能缺損已干擾個體最複雜的任務
4	輕度失智	工具性日常生活（IADL）受影響，如繳費、煮飯、打掃、外出旅行
5	中度失智	需要協助挑選合適衣著
6a	中重度失智	穿衣需要協助
6b	中重度失智	沐浴需要協助
6c	中重度失智	上廁所需要協助
6d	中重度失智	尿失禁
6e	中重度失智	糞失禁
7a	重度失智	白天可說出 5–6 個詞
7b	重度失智	僅能清楚說出 1 個詞
7c	重度失智	無法行走
7d	重度失智	無法獨立坐起
7e	重度失智	無法微笑
7f	重度失智	無法抬頭 / 支撐頭部

長照失能等級1~8

ADL

- 進食 (0-5-10)
- 下床移位(0-5-10-15)
- 大小便及如廁 (0-5-10-15)
- 洗澡/盥洗 (0-5-10)
- 行走平地(0-5-10-15)
- 穿脫衣服 (0-5-10)
- 上下樓梯(0-5-10)

IADL

- 食物烹調（0-3）上街購物（0-3）
- 外出交通（0-4） 家務維持（0-4）
- 洗衣服（0-2） 使用電話（0-3）
- 管理財務（0-2）管理藥物（0-3）

等級	ADL	IADL	說明
1	100	24	無失能
2	91~99	21~23	輕度失能
3	60~90	18~20	中度失能
4	30~60	15~17	中重度失能
5	15~30	12~14	重度失能
6	10~15	9~11	重度失能
7	5~10	6~8	極重度失能
8	0~5	0~5	極重度失能

五項中有三項以上需要協助者即為輕度失能。

國際失智症照護政策領先國家

借鑑國際經驗，建構臺灣失智症照護體系的政策藍圖

政策與治理

日本:全國級失智症行動計畫
結合全民長照保險
英國:National Dementia Strategy
整合衛政、社政、勞政資源

社區整合

日本:社區整合照護系統CBICS
醫療/長照/社政整合照護模式。社區失智症照護據點。
瑞典 / 丹麥:失智友善社區

生活照護與環境設計

荷蘭:失智村Hogeweyk去機構化。自主、熟悉、安全且具療癒性的生活空間

照顧者支持與專業隊伍

英國:系統化的家屬支持體系
照顧者喘息服務、支持團體與教育訓練。
專科照護模式，培育失智症照護專業人力
減輕家庭照顧負擔。

監測與品質

建立以WHO全球失智症觀測站（GDO）與OECD指標為基礎的持續監測機制。

這五大策略架構提供臺灣失智症照護政策發展的重要參考框架。透過系統性的政策設計、跨域整合與國際標準，我們能建構更完善的失智症照護體系，為高齡化社會的挑戰做好充分準備。

北卡羅來納州老年生活解決方案公司
NC Senior Living Solutions
旨在滿足那些即將把親人送入養老社區的家庭的需求

財務授權書、體檢結果和生前預囑。我們還將協助您協調搬家事宜，包括與首選搬家公司合作並監督整個入住流程。

老年護理選擇，包括：
獨立生活、
輔助生活、
記憶護理（失智症）、
專業養老院
護理、
CCRC（持續護理退休社區）

- Independent Living
- Assisted Living
- Memory Care (Dementia)
- Skilled Nursing
- CCRC (Continuing Care Retirement Communities)

評估摯愛的需求、確定所需的照護級別，並考慮您家人的優先事項。此外，我們將全程指導您。這可確保您減少困惑，並為您的摯愛帶來輕鬆無憂的體驗。

聯邦醫療保險和補充保險只涵蓋社區環境中的藥物治療、物理治療、語言治療和職業治療（取決於您選擇的計劃）。
聯邦醫療保險和補充保險不涵蓋長期照護社區的生活費用，也不涵蓋照護層面的費用。

加州大學舊金山分校ePrognosis 網站

Mitchell Index

•人口： 65 歲及以上的療養院成年人
•結果：6個月存活

六個月死亡率

積分	6個月死亡風險
1.0 - 6.4	7%
6.5 - 7.9	10%
8.0 - 8.9	13%
9.0 - 9.7	14%
9.8 - 10.5	17%
10.6 - 11.5	20%
11.6 - 12.5	23%
12.6 - 14.0	28%
14.1 - 16.1	34 - 43%
> 16.1	49 - 62%

「Mitchell Index（又稱 ADEPT）的可信度到哪裡」：是怎麼做出來的？用了21.8萬名美國護理之家住民的資料建立模型（多數是80–90歲、女性、白人），不是小樣本。有沒有在別的地方測試？有，在波士頓21家機構的606位重度失智者身上做外部驗證，代表不是只在原本那群人好用。準不準？（區辨力）c-statistic＝0.67 → 大約能67%正確區分「會在追蹤期內過世」與「不會過世」的人。50%＝像丟硬幣；0.67屬於中等，不是很神準，但有參考價值。預測值合不合理？（校準）用統計檢定看起來沒有明顯失準，也就是模型預測的風險大致和實際發生率能對得上。重點結論： 這個指數經過大樣本建立與外部驗證，中等準度、校準不差；可作為臨床討論與照護規劃的輔助參考，但不能單獨當作個別病人的「命運預言」，仍需結合臨床判斷與家屬目標。Mitchell Index

2017_60頁

失智症衛教及資源手冊



(三) 緩和安寧醫療的抉擇

隨著病情的進展，患者咽喉部肌肉功能會逐漸變差，吞嚥變困難、進食量變少、又無法透過餵食技巧來改善患者的吞嚥障礙，或反覆發生吸入性肺炎，醫生可能會建議插鼻胃管或是胃造管。此餵食管路可能是維繫患者生命的途徑，但是否真的能夠延長患者生命，目前仍然有爭論。對多數人來講，這是一個生活品質的問題，也是頗為難以抉擇的議題。

有些患者在多次呼吸道感染後，可能呼吸功能、排痰能力下降，有時在多次之後或某次急性搶救時，醫師可能會建議執行氣管切開，以處理排痰及呼吸阻塞的問題，家人可與醫師討論是否有其它方式可以處理，或是氣切是必須要做的抉擇。而在未發生此抉擇之前，是有一些預防之道，如：在患者出現吞嚥困難時，小心地餵食；避免感冒；痰多時，要給予適當的濕化痰液及胸腔物理療法，以協助排除痰液。照顧末期失智患者家人可能需提早討論在面對重要決定時，如何抉擇，同時思考患者本人的意願。

緩和療護是指對罹患威脅生命之重大疾病人者所進行的積極且全面性的照顧，包含：控制疼痛與其他症狀、解決心裡、社會及靈性問題。在台灣，許多民眾會對於緩和醫療字眼感到陌生與害怕，擔心是否代表放棄家人，然而緩和醫療的觀點應和治癒性治療同步並行，並隨著患者病程階段的改變而逐漸增加比例，以盡可能提升家庭的生活品質。

健保署自2009 年9 月1 日起，將包括失智症在內的八大非癌病末期患者的安寧緩和醫療納入健保給付，對於失智症病人來說，到達末期時，已是人生盡頭，且為不可逆，因此宜以安寧療護的理念來提供末期的失智病人及家屬全方位的照顧，對失智患者不刻意加速或延緩死亡的到來；提供身體、心理上舒適的照護；並提供家屬支持服務，讓家屬陪伴患者舒適平和活著直到辭世。失智症患者與其它疾病人者不同之處在於，患者本身一旦被診斷出失智症時，其認知及判斷力可能都已有某種程度之障礙，可能已無法表達放棄急救之基本權利的選擇；除非患者在未失智前曾明確表明不要急救的願望或已立下生前遺囑，否則在重度失智時，是否急救或積極治療的選擇就背負

在照顧的家屬身上。而決定者在事後也有可能因其他家人的抱怨，而對自我

產生懷疑，甚至有罪惡感。建議家屬適時與醫師溝通，必要時評估於醫院或

是居家進行安寧療護的需求，以獲得安寧服務團隊的支持與協助。

因此家族事先共同討論一個對患者最好的決定是必要的；如此患者在臨

終時才不會因緊急送醫時，接受許多不必要的積極性治療或急救措施。經過

衛生福利部
台灣病人安全資訊網
Taiwan Patient Safety Net

「餵」我自己做決定：當我失智變嚴重時是否要進行人工灌食？

2022-06-17

開發團隊、機構	臺北榮民總醫院神經內科及Ａ１６３病房

臺北市立聯合醫院
醫病共享決策輔助平台



當我面臨生命末期，我要不要接受人工營養和流...

了解更多+



失智症末期吞嚥困難進食方式選擇

了解更多+

臺北榮民總醫院安寧居家療護轉介醫囑單

一、 個案資料：

請貼 STICK 姓名、病歷號、出生日期 **診斷：**	**收案類別(請勾選)：** ☐ **惡性腫瘤末期** ☐ 不接受呼吸器處理之末期運動神經元疾病人者 ☐ 老年期及初老期器質性精神病態末期 ☐ 其他大腦變質末期 ☐ 末期心臟衰竭	☐ 末期慢性氣道阻塞疾病 ☐ 末期肺部其他疾病 ☐ 末期肝病及肝硬化 ☐ 急性腎衰竭末期 ☐ 慢性腎衰竭及腎衰竭末期 **（非癌末期條件詳見後頁附表）**

收案條件查檢表（全數勾選“是”，方符合收案）。

是	否	
☐	☐	病人或家屬同意接受安寧療護，並已簽署本院 DNR 意願書或健保 IC 卡已註記登錄「預立選擇安寧緩和醫療意願」。
☐	☐	病人或家屬是否了解為末期疾病，並確定對各種治癒性治療效果不佳。
☐	☐	病人是否為 **ECOG** 2 級以上或 Karnofsky Performance Scale 50-60 分。
☐	☐	病人或家屬了解需自行負擔安寧居家護理師來回計程車資。
☐	☐	病人居住地位於臺北市、新北市且距離臺北榮總 30 分鐘車程內。

疾病診斷與轉移處：_____

意識狀態：☐清醒 ☐嗜睡 ☐混亂 ☐昏迷：E__M__V__

主要聯絡人：_____ 與個案關係：_____ 聯絡電話：_____

居住地址：_____

二、個案主要安寧居家照護技術性需求項目：

留置管之定期更換: □鼻胃管 □導尿管 □氣切管　更換日與規格：_____

□傷口護理（壓傷/手術/腫瘤潰瘍）：_____

□造口護理：□人工肛門 □胃造口 □膀胱造口 □氣切造廔口 □PCN □其他_____

□止痛處置加藥、更換及皮下注射：_____

□人工血管之護理：沖洗時間及注意事項_____

□舒適護理 □善終準備 □身體其他照護需求_____

三、個案居家社會、心理及靈性照顧需求轉介：

□居家福利資源評估 □家庭功能評估與處遇 □預期性悲傷評估與處遇

□情緒狀態評估與處遇(□情緒低落 □生氣易怒 □恐懼害怕 □焦慮不安 □情緒變化大)

□行為狀態評估與處遇(□自傷傷人 □破壞行為 □迴避退縮 □自主尊嚴 □脫序行為)

□認知狀態評估與處遇(□自殺意念 □負向思考 □認知固著 □疑心妄想 □思考跳躍)

□生命與死亡之存在議題(死亡、孤獨、自由、無意義)的評估與處遇

□靈性阻礙與宗教信仰 □其它(如心理精神症狀、陪伴困難與壓力等)_____

四、目前病情及使用藥物：

_____

_____

轉介醫師蓋章：_____ **分機：**_____ **日期：**____年____月____日

- **4.1-4 機構失智症照顧床數 2,300 床**

- 4.1-4a 鼓勵布建失智症機構照顧床數　　截至113年底，失智照顧床數(含老人福利機構、身障機構、護理之家、榮民之家及部立醫院)共2,344床。依長期照顧服務法設立之住宿式服務類長照機構及含住宿式服務之綜合式長照機構，具行動能力失智開放床數為187床。　　衛生福利部
- 4.1-4b 鼓勵布建榮民之家失智床數 榮家失智專區之失智床數計667床，因臺南榮家新增35床，佳里榮家減12床(調整至安養)，爰較112年增加23床。　　國軍退除役官兵輔導委員會、衛生福利部
- 4.1-4c 輔導醫院成為失智友善醫院 1.輔導部屬醫院成為失智友善醫院，113年辦理成果如下：

失智者安寧緩和：5 個可複製做法（簡表｜版本 B）

建立失智專用臨床指引及工作表

- 症狀評估、吞嚥困難決策、呼吸窘迫、行為症狀、臨終鎮靜；參照英國 / 荷蘭在地化。
- 來源：N
  （ engla

導入臨終照護清單

- 跨醫療場域一致化流程與用語
- 紐:Te Ara Whakapiri

提早啟動 ACP / 目標一致醫療

- ACP 變成可追蹤流程
- 家庭會談、偏好紀錄、跨系統可見與數位簽署；

AIC 模式。
Agency for
ated Care (
)

建立機構重度失智末期照護流程

- 加拿大SPA-LTC
- 澳洲ELDAC
- 荷蘭老人醫師制度

推動可攜帶醫囑

POLST× AD / ACP 串接

- 急重症與在宅端目標一致(說同一種語言)
- 跨場域可執行性

建議先行：① 台灣版「最後幾日清單」 ② POLST × AD × ACP 串接 — 兩步驟快速提升目標一致醫療

IN-PEACE RCT trial
社區中重度失智症患者隨機對照試驗

- 結合安寧緩和照護的失智症照護管理(201對，觀察24個月)
  - 每週至少與患者進行1次面對面或2次電話互動
  - 減少急診與住院次數(1.06次 vs 2.37次)
  - 對神經精神症狀(NPI-Q)與照護者壓力(PHQ-8)的改善有限
  - 減少醫療資源使用上具實質效益。
- 結合ACP與安寧緩和照護的社區介入
  - 提升照護者滿意度Sachs 2025

PLAD 患者安寧療護的整合障礙

- 結合安寧緩和照護的失智症照護管理(201對，觀察24個月)
  - 人們尚未普遍認識到失智症是一種會導致死亡的末期障礙 [6]
  - 醫界無法辨識有病情惡化風險的 PLAD 弱勢族群 [7 , 8]。
  - 患者未能得到及時適當的未滿足需求的回應，
  - PLAD常常在三級醫療機構接受繁重的介入措施，這些介入措施既不能提高他們的生活品質，也不能增加他們的生活品質，他們只能在醫院裡度過人生的最後時光 [5 , 9 , 10]。
  - 隨著 PLAD 患者在不同醫療機構之間轉換，關於晚期疾病軌跡、護理討論目標和共同決策的溝通也變得支離破碎，導致患者、護理人員和醫療界的預後不佳 [8]。

晚期失智症死亡率預測模型(PRO - MADE)

1. 一年全因死亡率(ACM)的預測因子包括
   - 年齡 > 85 歲（OR：1.87；95%CI：1.36 至 2.56）、
   - 男性（OR：1.62；95%CI：1.18 至 2.22）、
   - 有肺炎（OR：1.75；95%CI：1.18 至 2.22）、
   - 有肺炎（OR：1.75；95%CI：1.25 至 2.45%）、2.505.509%： 4.31）、
   - 吞嚥困難（OR：1.53；95%CI：1.11 至 2.11）、
   - Charlson 合併症指數 ≥ 8（OR：1.39；95%CI：1.01 至 1.90）、
   - ≥ 4 項活動的功能依賴性（OR：1.82.95； 95%CI：1.58 至 2.95) 和
   - 異常白蛋白 (OR：3.68；95%CI：2.07 至 6.54) 值。
2. 模型的 AUC 為 0.70（95%CI：0.69 至 0.71）
3. 機率閾值大於或等於 0.4 的患者將入組接受低風險或高風險集束化治療方案中建議的介入措施(敏感性為 51.18%，特異性為 85.59%)。

Kaur, 2023

晚期失智症 PRO 預知模型(PRO - MADE)

- PLAD 患者通常在生命的最後一年住院，即使接受了治療，也更有可能在醫院去世 [2 , 16]。
- 即使被轉診接受安寧療護支持，也是在生命的最後幾天到幾週內；
- 超過 50% 的安寧療護計畫患者是在生命的最後一個月被轉診的 [2]。
- 患者未被轉診或轉診太晚的重要原因包括預後的不確定性，以及缺乏對晚期失智症安寧療護和相關資源的了解 [25 , 26]。
- 照護人員錯過了與臨床醫生坦誠討論晚期失智症家庭成員日益惡化的健康狀況的機會，也錯過了製定替代護理計劃的機會，該計劃側重於在患者最舒適的地方提供臨終關懷，以減輕痛苦。

晚期失智症 PRO 預知模型(PRO - MADE)

- **七個因素對於促進失智症患者良好的臨終關懷至關重要。**
  1. **及時的計劃性討論**
  2. **對臨終關懷的認知和支持性護理**
  3. **護理協調**
  4. **與初級保健機構建立有效的工作關係**
  5. **住院管理**
  6. **死後持續護理**
  7. **重視員工以及持續學習。**
  - **建議在失智症的整個病程中實踐這些因素[26]。**許多患者都希望在家中度過人生的最後時光，但只有少數阿茲海默症患者 (PLAD) 能夠做到這一點。

失智症緩和照護新框架—EMBED-Care

- 對可能影響失智症患者及其家人的症狀和問題進行整體評估和決策管理。
- 2019 年 1 月至2023/08➔ 2024 年 12 月
- 專為養護所（住宅）和社區失智症患者和家庭照護者使用而製定；
- 由 aTouchAway提供的數位應用程式交付。它包含五個主要部分：
  - 1) 使用綜合安寧療護結果量表-失智症 (IPOS-Dem) 對安寧療護需求進行整體評估；
  - 2) IPOS-Dem 評分預警系統，用於突出未滿足的需求；
    - 評分項目得分為 3-4 分時將觸發紅色警報
    - 系統使執業醫師、病人和/或照護者能夠共同做出決策，以支持優先次序的決策
  - 4) 臨床決策支援實證工具(rules of thumb)，可自動與已確定的需求關聯，從而管理照護；
  - 5) 為使用者提供的培訓包，包含面對面會議、接受額外面對面會議的臨床倡導者、涵蓋主要介入措施的動畫視訊和手冊，以及來自研究團隊的電子郵件和電話支援。

失智症緩和照護框架—EMBED-Care

Empowering Better End of Life Dementia Care

有 11 種需求或針對症狀的臨床決策支持工具：

1）精神、身份和幸福感；　2）譫妄；

3）飲食、飲水和口腔護理；　4）疼痛；

5）皮膚護理；　6）睡眠；

7）便秘和失禁；　8）感虛弱和缺乏能量；

9）活動能力；　10）保持情緒和心理健康；

11）護理人員的幸福感。

大多數工具包含三個階段：評估、原因分析、管理。

即使是新手用戶也能獲得支持並採取行動 [22, 23]。

針對失智症患者的預立醫療照護計畫（ACP）介入

- 歐洲安寧緩和照護學會（European Association for Palliative Care, EAPC）主導的33國Delphi研究明確指出，
- ACP應於失智症診斷初期即啟動，並根據患者認知能力動態調整，強調個別化、持續性溝通，並積極納入家屬參與。
- ACP流程需評估患者參與能力、選定代理決策者、建立多次對話機制，並在疾病進展時重點討論臨終照護議題。
- ACP的成功實施仰賴跨專業團隊協作、信任建立與衝突解決，並需定期檢視與更新照護計畫。[2-4]